



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PROMOSI KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS

Fenita Purnama Sari Indah • Katarina lit • Supriadi
Risna Nurlia • Sukmah Fitriani • Wittin Khairani
Fitriah

Editor: Nurlaili Ramli



BUNGA RAMPAI: PROMOSI KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS

Penulis:

Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

Katarina Iit, SST., M.Kes.

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M.

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Wittin Khairani, S.Pd., MPH.

Fitriah, S.K.M., M.K.M.

Editor:

Nurlaili Ramli, S.SiT., MPH.



Bunga Rampai: Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas

Penulis: Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

Katarina Iit, SST., M.Kes.

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M.

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Wittin Khairani, S.Pd., MPH.

Fitriah, S.K.M., M.K.M.

Editor: Nurlaili Ramli, S.SiT., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-52-7

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul "*Bunga Rampai: Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas*" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pendekatan komunitas dalam promosi kesehatan, terutama dalam era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika sosial budaya yang terus berubah.

Promosi kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan semata, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, serta pemanfaatan media dan teknologi informasi. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai perspektif dan strategi yang relevan untuk diterapkan dalam konteks komunitas yang beragam.

Beberapa topik utama yang dibahas meliputi peran teknologi dalam edukasi kesehatan masyarakat, pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi kesehatan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memperluas jangkauan dan dampak intervensi kesehatan. Selain itu, pendekatan budaya yang sensitif dan tepat sasaran juga menjadi fokus penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas.

Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama dalam promosi kesehatan, serta strategi pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas, turut menjadi sorotan penting dalam buku ini. Untuk memastikan efektivitas program, buku ini juga membahas metode evaluasi kampanye kesehatan agar dapat diukur dampaknya secara objektif dan berkelanjutan.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERAN TEKNOLOGI DALAM EDUKASI KESEHATAN

MASYARAKAT	1
Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Teknologi Digital	1
C. Peran Teknologi dalam Edukasi Kesehatan Masyarakat	2
D. Manfaat Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi Kesehatan Masyarakat	4
E. Tantangan dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi Kesehatan	5
F. Dampak Negatif dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi Kesehatan	6
G. Peran Penelitian yang Memanfaatkan Teknologi dalam Memberikan Edukasi	7
H. Pengabdian Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi dalam Memberikan Edukasi	9
I. Kesimpulan	11
J. Referensi	12
K. Glosarium	12

CHAPTER 2 PROMOSI KESEHATAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Katarina Iit, SST., M.Kes.	13
A. Pendahuluan/Prolog	13
B. Promosi Kesehatan	15
C. Media Sosial	21
D. Hambatan dalam mengakses promosi sosial melalui media sosial	25
E. Simpulan	26
F. Referensi	28
G. Glosarium	28

CHAPTER 3 KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PROMOSI KESEHATAN

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.	29
A. Pendahuluan	29
B. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan	30
C. Simpulan	45
D. Referensi	45

E. Glosarium	48
--------------------	----

CHAPTER 4 PENDEKATAN BUDAYA DALAM PROMOSI KESEHATAN

KOMUNITAS49

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M.....	49
A. Pendahuluan	49
B. Pengaruh Budaya Terhadap Kesehatan	50
C. Contoh Pengaruh Budaya Terhadap Kesehatan.....	51
D. Pendekatan Budaya dalam Promosi Kesehatan.....	53
E. Studi Kasus.....	56
F. Rekomendasi.....	57
G. Simpulan	58
H. Referensi	59

CHAPTER 5 STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

PROMOSI KESEHATAN61

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.....	61
A. Pendahuluan/Prolog	61
B. Pemberdayaan Masyarakat/ Community Empowerment.....	62
C. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	69
D. <i>Evidence Based –Community Empowerment</i>	70
E. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat	71
F. Kesimpulan.....	71
G. Referensi	72
H. Glosarium	73

CHAPTER 6 PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

BERBASIS KOMUNITAS75

Wittin Khairani, S.Pd., MPH.	75
A. Pendahuluan/Prolog	75
B. Perawatan Kesehatan berbasis Komunitas	77
C. Program Pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas.....	82
D. Hambatan dalam Upaya Pemberantasan Penyakit Menular Berbasis Komunitas dengan Pemberdayaan Masyarakat	87
E. Kesimpulan.....	87
F. Referensi	88

CHAPTER 7 EVALUASI EFEKTIVITAS KAMPANYE KESEHATAN.....91

Fitriah, S.K.M., M.K.M.	91
A. Pendahuluan	91
B. Prinsip Kampanye Kesehatan yang Efektif	93

C. Indikator Evaluasi Kampanye Kesehatan	95
D. Metode Evaluasi Kampanye Kesehatan.....	96
E. Implementasi Evaluasi Kampanye Kesehatan.....	98
F. Tantangan Evaluasi Kampanye Kesehatan.....	99
G. Strategi Mengatasi Tantangan.....	100
H. Kesimpulan.....	100
I. Referensi	101
PROFIL PENULIS	103

CHAPTER 1

PERAN TEKNOLOGI DALAM EDUKASI KESEHATAN MASYARAKAT

Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Teknologi tidak hanya memengaruhi cara kita mengakses informasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan masyarakat. Edukasi kesehatan adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pengelolaan kesehatan. Dalam konteks ini, teknologi dapat berperan sebagai alat yang efektif untuk menyebarkan informasi, meningkatkan interaksi, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya kesehatan yang lebih baik. Makalah ini akan membahas bagaimana peran teknologi dalam edukasi kesehatan masyarakat, serta tantangan dan manfaat yang dihadirkan oleh pemanfaatan teknologi tersebut.

B. Konsep Teknologi Digital

Teknologi digital adalah teknologi yang memproses, menyimpan, dan mentransmisikan data dalam bentuk digital, yaitu representasi data menggunakan kode biner (0 dan 1). Teknologi ini menggantikan sistem analog tradisional dengan metode yang lebih efisien, cepat, dan akurat (Aksenta, dkk, 2023).

Teknologi digital adalah rangkaian teknologi yang menggunakan sistem berbasis komputer dan perangkat elektronik untuk menciptakan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan data dalam bentuk digital (0 dan 1). Teknologi ini menggantikan metode analog dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan akurat.. Ciri-Ciri Teknologi Digital (Asari, dkk, 2023) :

1. Berbasis Data Biner: Informasi dikonversi ke dalam format digital (0 dan 1), yang memudahkan pemrosesan dan penyimpanan.
2. Fleksibilitas: Dapat digunakan dalam berbagai perangkat seperti komputer, ponsel pintar, tablet, dan perangkat IoT (Internet of Things).
3. Interkonektivitas: Mendukung komunikasi dan konektivitas global melalui jaringan internet.

4. Reproduksi Akurat: Data digital dapat digandakan tanpa kehilangan kualitas, berbeda dengan teknologi analog.

Contoh Teknologi Digital:

1. Perangkat Elektronik: Komputer, smartphone, tablet, dan kamera digital.
2. Komunikasi Digital: Media sosial, email, dan platform pemesanan instan.
3. Sistem Informasi: Basis data, cloud computing, dan teknologi blockchain.
4. Otomasi dan AI: Robotik, kecerdasan buatan (AI), dan pembelajaran mesin.
5. Multimedia Digital: Video streaming, musik digital, dan aplikasi editing.

Manfaat Teknologi Digital:

1. Efisiensi: Mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan.
2. Kemudahan Akses: Memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja.
3. Inovasi: Membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis.
4. Penghematan Biaya: Mengurangi kebutuhan akan sumber daya fisik seperti kertas dalam dokumentasi.
5. Transformasi gaya hidup: Mempermudah kegiatan sehari-hari, seperti belanja online, belajar jarak jauh, atau konsultasi kesehatan.

Secara keseluruhan, teknologi digital menjadi tulang punggung transformasi di berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan solusi yang lebih canggih dan terkoneksi untuk tantangan modern.

C. Peran Teknologi dalam Edukasi Kesehatan Masyarakat

Adapun peran teknologi dalam edukasi kesehatan masyarakat yaitu (Diyan, dkk, 2024):

1. Akses Informasi Kesehatan yang Lebih Cepat dan Luas

Salah satu peran utama teknologi dalam edukasi kesehatan masyarakat adalah memberikan akses informasi kesehatan yang cepat dan luas. Sebelumnya, penyebaran informasi kesehatan bergantung pada metode konvensional seperti brosur, pamflet, atau seminar yang terbatas pada lokasi dan waktu tertentu. Namun, dengan adanya teknologi internet, aplikasi, dan platform digital, informasi kesehatan kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Situs web, media sosial, dan aplikasi kesehatan memberikan berbagai informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan penyuluhan mengenai gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, vaksinasi, serta tips kesehatan lainnya dapat dijangkau oleh lebih banyak orang.

2. Penyuluhan Kesehatan melalui Media Sosial

Media sosial telah menjadi salah satu platform penting untuk edukasi kesehatan. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan

YouTube, organisasi kesehatan dan tenaga medis dapat berbagi informasi terkini mengenai kesehatan, baik dalam bentuk artikel, video, infografis, maupun live session. Penggunaan media sosial juga memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai topik kesehatan tertentu. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk belajar lebih dalam dan menyebarkan informasi tersebut ke komunitas mereka.

3. *Telemedicine* dan Konsultasi Kesehatan Jarak Jauh

Telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat mengatasi keterbatasan dalam akses layanan kesehatan. Melalui platform *telemedicine*, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis tanpa harus pergi ke fasilitas kesehatan. Teknologi ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kesulitan mengakses layanan kesehatan secara langsung. Selain itu, aplikasi *telemedicine* juga sering menyediakan fitur edukasi terkait gejala penyakit, pengobatan, dan tips perawatan diri yang membantu masyarakat menjaga kesehatan secara mandiri.

4. Aplikasi Kesehatan untuk Pemantauan Kesehatan Pribadi

Aplikasi kesehatan yang tersedia di perangkat seluler memberikan manfaat besar dalam edukasi kesehatan masyarakat. Aplikasi-aplikasi ini sering kali menawarkan fitur untuk memantau kesehatan pribadi, seperti pengukuran detak jantung, tekanan darah, kadar gula darah, serta rutinitas olahraga dan pola makan. Selain itu, beberapa aplikasi juga menyediakan informasi edukatif mengenai penyakit, pengobatan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat lebih sadar tentang kondisi kesehatan mereka dan lebih proaktif dalam menjaga kesehatan.

5. Edukasi Kesehatan Melalui Gamifikasi

Teknologi juga memungkinkan penggunaan pendekatan inovatif dalam edukasi kesehatan melalui gamifikasi. Dalam gamifikasi, elemen-elemen permainan digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Beberapa aplikasi dan game edukasi kesehatan mengajak penggunanya untuk belajar tentang kesehatan melalui tantangan atau simulasi yang melibatkan partisipasi aktif. Misalnya, permainan yang mengajarkan cara-cara cuci tangan yang benar, pentingnya pola makan sehat, atau cara menangani situasi darurat medis. Pendekatan ini dapat membantu masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, untuk memahami konsep-konsep kesehatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat.

D. Manfaat Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi Kesehatan Masyarakat

Teknologi digital menjadi fondasi utama dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari pendidikan, komunikasi, bisnis, hingga kesehatan. Penggunaannya yang terus berkembang memungkinkan solusi inovatif untuk tantangan di masa depan. Adapun manfaat Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi Kesehatan Masyarakat, yaitu

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Kesehatan.

Dengan adanya teknologi, informasi kesehatan dapat disebarluaskan secara lebih luas dan cepat. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan yang sedang berkembang, seperti penyakit menular, pola makan sehat, dan pentingnya olahraga. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit dan perawatan diri juga meningkat, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi angka kejadian penyakit dan perawatan rumah sakit.

2. Akses yang Lebih Terjangkau dan Merata

Teknologi, terutama internet, memungkinkan akses pendidikan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata. Sebelumnya, banyak informasi kesehatan hanya tersedia di kota-kota besar atau melalui biaya yang cukup tinggi untuk konsultasi dengan tenaga medis. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan geografi dapat mengakses informasi yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

3. Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Pemanfaatan teknologi dalam edukasi kesehatan juga dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dengan adanya platform online dan aplikasi yang memungkinkan pengukuran dan pemantauan kesehatan pribadi, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga gaya hidup sehat. Teknologi ini juga memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman dan tips kesehatan dengan sesama, menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup sehat.

Teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam edukasi kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak positif dan tantangan yang muncul akibat penerapan teknologi dalam bidang ini (Asrin, dkk, 2024):

1. Akses Informasi yang Lebih Luas:

- a. Teknologi, terutama internet, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan kapan saja dan di mana saja.

- b. *Platform* seperti situs web kesehatan, aplikasi mobile, dan media sosial menyediakan informasi tentang pencegahan penyakit, gaya hidup sehat, dan pengobatan.

2. Pendidikan Interaktif dan Personalisasi:

- a. Aplikasi dan alat berbasis teknologi memungkinkan penyampaian edukasi kesehatan yang interaktif, seperti video animasi, webinar, dan pelatihan online.
- b. Algoritma kecerdasan buatan (AI) dapat memberikan rekomendasi kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

3. Peningkatan Kesadaran melalui Media Sosial:

- a. Kampanye kesehatan dapat dengan cepat menjangkau banyak orang melalui media sosial, seperti promosi vaksinasi, kebersihan, dan pola makan sehat.
- b. Influencer dan komunitas digital juga membantu menyebarkan pesan kesehatan secara efektif.

4. Pemantauan dan Manajemen Kesehatan:

- a. Teknologi wearable (seperti smartwatch) memungkinkan pemantauan kesehatan individu, seperti detak jantung, tingkat stres, atau kualitas tidur.
- b. Data dari perangkat ini dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat.

5. *Telemedicine* dan Konsultasi Jarak Jauh:

- a. Teknologi memungkinkan akses ke layanan kesehatan melalui *telemedicine*, terutama di daerah terpencil.
- b. Konsultasi online mempermudah masyarakat mendapatkan edukasi langsung dari tenaga kesehatan.

E. Tantangan dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi Kesehatan

Terdapat tantangan dalam pemanfaatan teknologi untuk edukasi kesehatan (Asrin, dkk, 2024):

1. Keterbatasan Akses Teknologi di Beberapa Wilayah

Meski teknologi telah berkembang pesat, akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, masih terbatas. Hal ini menghambat penyebaran informasi kesehatan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan akses teknologi yang lebih luas, seperti penyediaan fasilitas internet di daerah-daerah yang membutuhkan.

2. Keamanan dan Privasi Data Kesehatan

Penggunaan aplikasi dan platform kesehatan memerlukan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi pengguna, seperti informasi medis, riwayat kesehatan, dan kebiasaan hidup. Isu terkait dengan privasi dan keamanan data

menjadi tantangan utama, karena kebocoran atau penyalahgunaan data kesehatan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi individu.

3. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat

Dengan kemudahan akses informasi melalui internet, ada risiko penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat atau menyesatkan. Hoaks atau informasi yang salah tentang kesehatan bisa sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sumber informasi yang berbasis teknologi untuk disaring dan diverifikasi dengan benar oleh ahli kesehatan yang kredibel.

F. Dampak Negatif dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi Kesehatan

Teknologi, meskipun membawa banyak manfaat dalam edukasi kesehatan masyarakat, juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut adalah dampak-dampak negatifnya:

1. Penyebaran Disinformasi dan Misinformasi

- a. Masalah: Informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau palsu terkait kesehatan dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan internet.
- b. Akibat: Masyarakat dapat mengambil keputusan kesehatan yang salah, seperti penggunaan obat yang tidak terbukti, menolak vaksinasi, atau mempercayai mitos kesehatan.

2. Disinformasi dan Misinformasi:

- a. Banyak informasi kesehatan yang tidak akurat atau menyesatkan beredar di internet dan media sosial, yang dapat membahayakan masyarakat.
- b. Masalah: Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, baik karena faktor ekonomi, infrastruktur, atau literasi digital.
- c. Akibat: Kelompok yang kurang terpapar teknologi, seperti masyarakat pedesaan atau kelompok rentan, bisa tertinggal dalam mendapatkan informasi kesehatan yang akurat.

3. Kesenjangan Digital:

- a. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses ke teknologi atau kemampuan menggunakan perangkat digital, sehingga menciptakan ketimpangan dalam akses edukasi kesehatan.
- b. Masalah: Teknologi bisa membuat masyarakat terlalu bergantung pada aplikasi atau perangkat tanpa berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan.
- c. Akibat: Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kesehatan atau pengobatan sendiri yang berisiko.

4. Privasi dan Keamanan Data:

- a. Penggunaan teknologi untuk edukasi kesehatan sering melibatkan data pribadi. Risiko kebocoran data dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.
- b. Masalah: Aplikasi kesehatan dan platform digital sering mengumpulkan data pribadi, seperti riwayat kesehatan dan kebiasaan pengguna.
- c. Akibat: Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data dapat mengancam privasi pengguna dan mengurangi kepercayaan terhadap teknologi.

5. Kurangnya Literasi Digital:

- a. Beberapa kelompok masyarakat mungkin kesulitan memahami atau memanfaatkan teknologi secara efektif, terutama generasi yang lebih tua.
- b. Masalah: Sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam memahami atau menggunakan teknologi secara benar.
- c. Akibat: Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi informasi kesehatan atau penggunaan aplikasi yang tidak tepat.

6. Ketergantungan pada Teknologi:

Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung dengan tenaga kesehatan yang masih sangat penting dalam edukasi kesehatan.

7. Overload Informasi (*Information Overload*)

- a. Masalah: Internet menyediakan terlalu banyak informasi kesehatan, yang sering kali sulit disaring oleh masyarakat awam.
- b. Akibat: Kebingungan dalam membedakan informasi yang valid dan yang tidak, sehingga memperburuk pemahaman kesehatan.

8. Pengurangan Interaksi Manusia

- a. Masalah: Penggunaan teknologi seperti aplikasi kesehatan atau telemedicine dapat mengurangi interaksi langsung dengan tenaga kesehatan.
- b. Akibat: Kualitas komunikasi dan hubungan pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dapat menurun, sehingga edukasi kesehatan menjadi kurang efektif.

9. Komersialisasi yang Berlebihan

- a. Masalah: Banyak platform kesehatan yang lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan memberikan informasi yang benar dan bermanfaat.
- b. Akibat: Edukasi kesehatan sering kali tergeser oleh iklan, promosi produk kesehatan, atau layanan berbayar yang tidak selalu relevan atau efektif.

G. Peran Penelitian yang Memanfaatkan Teknologi dalam Memberikan Edukasi

Penelitian yang memanfaatkan teknologi dalam memberikan edukasi telah berkembang pesat di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan formal,

pelatihan kerja, dan pengembangan masyarakat (Ratnaningtyas, dkk, 2022). Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang relevan:

1. Teknologi dalam Edukasi Kesehatan

- a. Studi: Penggunaan aplikasi *mobile* untuk meningkatkan kesadaran akan diabetes.
 - 1) Deskripsi: Penelitian mengembangkan aplikasi berbasis smartphone yang memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, pengelolaan kadar gula darah, dan pengingat obat untuk penderita diabetes.
 - 2) Hasil: Aplikasi ini meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan hingga 30% dan meningkatkan pemahaman mereka tentang penyakit.
- b. Studi: *Telemedicine* untuk edukasi kesehatan ibu hamil.
 - 1) Deskripsi: Penelitian mengevaluasi efektivitas *telemedicine* dalam memberikan informasi tentang kehamilan, nutrisi, dan perawatan bayi baru lahir.
 - 2) Hasil: Ditemukan bahwa ibu hamil yang menggunakan platform *telemedicine* lebih memahami risiko kehamilan dibandingkan dengan yang tidak.

2. Teknologi dalam Pendidikan Formal

- a. Studi: Penggunaan game edukasi berbasis virtual reality (VR) dalam pembelajaran sains.
 - 1) Deskripsi: Penelitian ini mengembangkan game VR untuk mengajarkan konsep fisika kepada siswa sekolah menengah.
 - 2) Hasil: Siswa yang belajar menggunakan VR memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep abstrak dibandingkan metode konvensional.
- b. Studi: Implementasi platform pembelajaran adaptif berbasis AI.
 - 1) Deskripsi: Penelitian memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa.
 - 2) Hasil: Platform ini meningkatkan hasil belajar hingga 20% karena mampu menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar siswa.

3. Teknologi dalam Pelatihan dan Pengembangan Kerja

- a. Studi: Penggunaan simulasi berbasis augmented reality (AR) dalam pelatihan medis.
 - 1) Deskripsi: Penelitian ini menggunakan teknologi AR untuk melatih mahasiswa kedokteran melakukan prosedur bedah.
 - 2) Hasil: AR memberikan pengalaman realistis yang meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa tanpa risiko terhadap pasien.

- b. Studi: E-learning untuk pelatihan karyawan di perusahaan multinasional.
 - 1) Deskripsi: Penelitian mengevaluasi efektivitas platform e-learning dalam melatih karyawan tentang teknologi baru dan keterampilan manajemen.
 - 2) Hasil: Program e-learning ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya pelatihan hingga 50%.

4. Teknologi dalam Edukasi Masyarakat Umum

- a. Studi: Kampanye kesehatan berbasis media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi.
 - 1) Deskripsi: Penelitian mengevaluasi dampak kampanye berbasis Instagram dan Facebook dalam meningkatkan penerimaan vaksinasi pada kelompok usia muda.
 - 2) Hasil: Kampanye tersebut meningkatkan niat vaksinasi sebesar 40% di kelompok sasaran.
- b. Studi: Penggunaan chatbot berbasis AI untuk edukasi kebersihan.
 - 1) Deskripsi: Penelitian menggunakan chatbot untuk memberikan informasi tentang praktik kebersihan, seperti mencuci tangan dan sanitasi.
 - 2) Hasil: *Chatbot* meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebersihan hingga 25% dibandingkan penyebaran pamflet tradisional.

Penelitian yang memanfaatkan teknologi dalam edukasi telah menunjukkan hasil yang positif, seperti peningkatan pemahaman, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran. Teknologi seperti aplikasi mobile, VR, AR, AI, dan media sosial menjadi alat yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan pengalaman edukasi yang lebih interaktif dan personal.

H. Pengabdian Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi dalam Memberikan Edukasi

Pengabdian masyarakat yang memanfaatkan teknologi dalam memberikan edukasi merupakan salah satu cara efektif untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan pengabdian masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam edukasi:

1. Program Literasi Digital untuk Pelajar

- a. Deskripsi: Mengadakan pelatihan tentang penggunaan internet secara aman dan produktif untuk siswa sekolah menengah.
- b. Tujuan: Membantu siswa memahami cara mencari informasi yang akurat, menggunakan media sosial secara bijak, dan menghindari disinformasi.
- c. Teknologi yang Digunakan: Laptop, proyektor, aplikasi e-learning seperti *Google Classroom* atau Canva, dan akses internet.

2. Pelatihan Teknologi Pertanian Berbasis IoT

- a. Deskripsi: Memberikan edukasi kepada petani tentang penggunaan perangkat IoT (*Internet of Things*) untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan irigasi.
- b. Tujuan: Meningkatkan hasil pertanian melalui teknologi modern.
- c. Teknologi yang Digunakan: Sensor IoT untuk tanah dan cuaca, aplikasi monitoring berbasis smartphone, dan drone untuk pengawasan lahan.

3. Workshop Kesehatan Berbasis Telemedicine

- a. Deskripsi: Mengedukasi masyarakat pedesaan tentang cara menggunakan aplikasi *telemedicine* untuk berkonsultasi dengan dokter dan memesan obat secara online.
- b. Tujuan: Memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sulit dijangkau secara fisik.
- c. Teknologi yang Digunakan: Smartphone, aplikasi kesehatan seperti Halodoc atau Alodokter, dan jaringan internet.

4. Program Edukasi UMKM Digital

- a. Deskripsi: Melatih para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk, seperti membuat toko online atau menggunakan media sosial untuk promosi.
- b. Tujuan: Membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan.
- c. Teknologi yang Digunakan: Marketplace, media sosial (*Instagram, Facebook*), dan alat desain grafis sederhana seperti Canva.

5. Pelatihan Keterampilan Digital untuk Generasi Muda

- a. Deskripsi: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan teknologi, seperti coding, desain grafis, dan video editing, untuk pemuda di daerah terpencil.
- b. Tujuan: Memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern.
- c. Teknologi yang Digunakan: Laptop, software desain (*Photoshop, Illustrator*), dan platform pembelajaran seperti *Coursera* atau Khan Academy.

6. Kampanye Edukasi Lingkungan Berbasis Media Digital

- a. Deskripsi: Membuat kampanye digital tentang pentingnya daur ulang, pengurangan sampah plastik, dan penghijauan melalui media sosial.
- b. Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.
- c. Teknologi yang Digunakan: Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan konten edukasi.

7. Kelas Parenting Online

- a. Deskripsi: Menyediakan kelas parenting online untuk orang tua muda, dengan materi seperti pengasuhan anak, manajemen emosi, dan pengembangan anak.

- b. Tujuan: Membantu orang tua dalam memahami cara mendidik anak di era digital.
- c. Teknologi yang Digunakan: Platform video conference seperti *Zoom* atau *Google Meet*, serta grup diskusi di *WhatsApp*.

8. Digitalisasi Perpustakaan Desa

- a. Deskripsi: Membantu desa mendigitalisasi perpustakaan mereka sehingga buku-buku dan sumber daya lainnya dapat diakses secara online.
- b. Tujuan: Mempermudah akses masyarakat terhadap literatur pendidikan.
- c. Teknologi yang Digunakan: Scanner, sistem manajemen perpustakaan digital (*e-library*), dan *cloud storage*.

9. Edukasi Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Digital

- a. Deskripsi: Mengajarkan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, cara menggunakan aplikasi keuangan digital seperti e-wallet untuk pembayaran dan pencatatan keuangan.
- b. Tujuan: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memudahkan mereka dalam transaksi digital.
- c. Teknologi yang Digunakan: Aplikasi e-wallet (GoPay, OVO), aplikasi pencatatan keuangan seperti BukuWarung, dan smartphone.

10. Program Pembelajaran Bahasa Berbasis Aplikasi

- a. Deskripsi: Membantu anak-anak di daerah terpencil belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa.
- b. Tujuan: Meningkatkan kemampuan berbahasa asing untuk membuka peluang pendidikan dan pekerjaan.
- c. Teknologi yang Digunakan: Aplikasi seperti Duolingo, Babbel, atau Rosetta Stone.

Pengabdian masyarakat yang memanfaatkan teknologi tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memberdayakan individu dan komunitas untuk menghadapi tantangan di era digital. Kombinasi antara teknologi dan pendekatan humanis adalah kunci keberhasilan program-program tersebut.

I. Kesimpulan

Teknologi telah membawa revolusi besar dalam edukasi kesehatan masyarakat, meningkatkan akses, efektivitas, dan jangkauan program kesehatan. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, penting untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti kesenjangan digital, misinformasi, dan keamanan data. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan teknologi dapat digunakan secara inklusif dan bertanggung jawab.

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam edukasi kesehatan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi, informasi kesehatan dapat disebarkan lebih cepat dan luas, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Meskipun ada tantangan terkait akses, privasi, dan akurasi informasi, manfaat yang diberikan oleh teknologi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan sangat signifikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, penyedia layanan kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri, untuk terus berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

J. Referensi

- Aksenta, A., Irmawati, I., Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, S., Herlinah, H., ... & Ginting, T. W. (2023). *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asari, A., Syaifuddin, E. R., Ningsi, N., Maria, H. D., Adhicandra, I., Nuraini, R., ... & Murti, S. (2023). Komunikasi Digital.
- Asrin, F., Anra, H., Irwansyah, M. A., & Pratama, E. E. (2024). Pemahaman Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Komputer Di Bidang Kesehatan. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(2), 159-168.
- Diyan, D. Z., Nurdin, A., Fitria, U., & Kurnia, R. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan masyarakat. *Public Health Journal*, 1(2).
- Ratnaningtyas, T. O., Indah, F. P. S., & Ilmi, A. F. (2022). Effectiveness of a live-chat social media and leaflets for people living with HIV/AIDS (PLWHA) under antiretroviral therapy (ARVs). *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, 5(2), 116-123.

K. Glosarium

AI	: Artificial Intelligence
AR	: augmented reality
IoT	: Internet of Things
TIK	: teknologi informasi dan komunikasi
UMKM	: usaha mikro, kecil, dan menengah

CHAPTER 2

PROMOSI KESEHATAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Katarina Iit, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu - individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan mengandal kan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Sedangkan Indonesia merumuskan pengertian promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (mandiri) serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang-orang untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan mereka dan penentu-penentunya, dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Definisi ini dinyatakan dalam Piagam Bangkok tentang Promosi Kesehatan di Dunia Global yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2005.

Promosi kesehatan selaras dengan konsep kesetaraan kesehatan dan dapat dijadikan fokus oleh lembaga swadaya masyarakat yang mendedikasikan diri untuk mewujudkan keadilan sosial atau hak asasi manusia. Literasi kesehatan dapat dikembangkan di sekolah-sekolah, sedangkan aspek promosi kesehatan seperti promosi menyusui bergantung pada aturan hukum, termasuk aturan di ruang publik. Salah satu butir Aksi Promosi Kesehatan dalam Piagam Ottawa adalah menanamkan pentingnya tindakan pencegahan kepada semua sektor masyarakat sehingga upaya preventif lebih diutamakan dibandingkan upaya kuratif.

Organisasi Kesehatan Dunia membuat logo promosi kesehatan dengan elemen grafis berupa sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat tiga sayap dan satu lingkaran. Lingkaran luar diartikan sebagai perwakilan dari kebijakan publik yang sehat yang ditetapkan bersama. Tiga sayap di dalam lingkaran diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan promosi kesehatan. Sedangkan lingkaran kecil di dalam lingkaran luar diartikan sebagai strategi dasar dalam promosi kesehatan. Tiga sayap menyelesaikan lima permasalahan utama di bidang promosi kesehatan, sedangkan lingkaran yang lebih kecil mencakup tiga strategi dasar di bidang promosi kesehatan.

Promosi kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor penguat dan faktor pemungkin. Faktor predisposisi mencakup riwayat keperawatan, aspek sosial dan budaya, kondisi fisik, motivasi dan kesiapan peserta promosi untuk belajar. Faktor penguat merupakan segala faktor yang menentukan ada tidaknya dukungan yang diberikan kepada tindakan kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin meliputi sumber daya dan keterampilan yang berguna dalam memperlihatkan perilaku yang sehat. Selain mengkaji faktor-faktor kesehatan, promosi kesehatan memerlukan kepedulian individu untuk menyesuaikan kebutuhan pasien dan keluarganya. Kegiatan promosi kesehatan juga perlu melibatkan pasien dalam perencanaan perawatan serta menghubungkan pasien dengan sumber daya masyarakat.

Pada tahun 1994, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan tiga strategi promosi kesehatan. Ketiganya yaitu advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan bahwa promosi kesehatan di tempat kerja merupakan segala kebijakan dan kegiatan yang berlaku di tempat kerja yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat di tempat kerja. Pihak-pihak ini meliputi pekerja dan perusahaan pada semua tingkat pekerjaan. Kegiatan promosi kesehatan ini melibatkan pekerja, pihak manajemen dan pemangku kepentingan di tempat kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114 /MENKES/SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai social budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes, 2011).

Jadi, media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang iniantara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Media promosi kesehatan meliputi semua media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dapat mengubah perilaku kesehatan dari penerima informasi menjadi lebih baik. Bentuk medianya dapat berupa media cetak, media elektronik dan media yang digunakan di luar ruangan. Media juga dapat digabungkan dengan alat peraga. Kombinasi ini misalnya pemakaian foto dan papan tulis. Alat peraga sendiri dapat digunakan secara tunggal, tetapi harus mudah dipahami oleh masyarakat yang menerima informasi tersebut.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Di Era digital yang dikenal dengan Web 2.0 atau Health 2.0 atau Medicine 2.0 menjadikan masyarakat sehat dan pasien lebih mengandalkan internet daripada dokter sebagai sumber informasi perawatan kesehatan. Situs web media sosial yang populer terbukti efektif dan ampuh untuk menyebarkan informasi kesehatan, mendukung upaya promosi kesehatan dan dapat ditelusuri secara online seperti YouTube, Facebook, MySpace, Twitter, dan Second Life serta image sharing, mobile technology dan blog. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan kegiatan promosi kesehatan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari melalui media Twitter, Facebook, Instagram, Youtube yang berisi konten kesehatan berupa foto, video, dan poster.

B. Promosi Kesehatan

1. Pengertian Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang-orang untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan mereka dan penentu-penentunya, dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Definisi ini dinyatakan dalam Piagam Bangkok tentang Promosi Kesehatan di Dunia Global yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2005.

Promosi kesehatan di Indonesia sebelumnya dikenal dengan Penyuluhan Kesehatan. Perubahan penyebutan Penyuluhan Kesehatan menjadi Promosi Kesehatan dipengaruhi oleh perkembangan di dunia karena munculnya Konferensi Internasional tentang Pencegahan (prevention) pada tahun 1986 di Kanada yang dikenal dengan nama Ottawa Charter (Syafei, 2010). Ottawa Charter merupakan konferensi internasional pertama tentang Promosi Kesehatan yang diselenggarakan oleh WHO (World Health Organization).

Promosi kesehatan merupakan Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan sasaran akhir dari pembangunan kesehatan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan upaya yang sistematis dan terprogram melalui pendidikan non-formal, serta usaha pemberdayaan sehingga masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun komunitas, mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dalam bidang kesehatan, serta berperilaku sehat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Notoatmodjo (2014), "Promosi kesehatan merupakan suatu bentuk pendidikan yang berupaya agar masyarakat berperilaku kesehatan yang

baik.” Sedangkan menurut Dinas Kesehatan (2008), “ Promosi Kesehatan adalah proses 6 Windi Chusniah Rachmawati mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Akan Tetapi menurut Syarifudin (2009), “Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya melalui pembelajaran.”

2. Tujuan Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan baik individu meningkatkan kemampuan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber pada masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk mendorong terbentuknya kemampuan tersebut (Notoatmodjo, 2012).

3. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan

Berdasarkan Piagam Ottawa tahun 1986 dalam Widi 2019, ruang lingkup promosi kesehatan dikelompokkan menjadi lima area yaitu:

a. Build Healthy Policy

Build Healthy Policy atau membangun kebijakan publik yang berwawasan kesehatan memperhatikan dampak kesehatan dari setiap keputusan yang telah dibuat. Kebijakan publik sebaiknya menguntungkan kesehatan. Bentuk kebijakan publik antara lain berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal, kebijakan pajak dan pengembangan organisasi serta kelembagaan. Berikut contoh-contoh bentuk kebijakan di Indonesia:

- 1) Kebijakan kawasan tanpa rokok
- 2) Pembatasan iklan rokok
- 3) Pemakaian helm dan sabuk pengaman

b. Create Supportive Environment

Create Supportive Environment atau menciptakan lingkungan yang mendukung merupakan peranan yang besar untuk mendukung seseorang atau mempengaruhi kesehatan dan perilaku seseorang. Berikut merupakan contoh lingkungan yang mendukung:

- 1) Penyediaan pojok laktasi di tempat-tempat umum
- 2) Penyediaan tempat sampah
- 3) Pengembangan tempat konseling remaja

c. *Strengthen Community Action*

Strengthen Community Action atau memperkuat gerakan masyarakat. Promosi kesehatan berperan untuk mendorong serta memfasilitasi upaya masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Berikut contoh-contoh penguatan gerakan masyarakat:

- 1) Terbentuknya yayasan atau lembaga konsumen kesehatan
- 2) Terbentuknya posyandu
- 3) Terbentuknya pembiayaan kesehatan bersumber daya masyarakat

d. *Develop Personal Skill*

Develop Personal Skill atau mengembangkan keterampilan individu merupakan upaya agar masyarakat mampu membuat keputusan yang efektif tentang kesehatannya. Masyarakat membutuhkan informasi, pendidikan, pelatihan dan berbagai keterampilan. Promosi Kesehatan berperan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil keputusan dan mengalihkan tanggung jawab kesehatan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan setiap individu. Pemberdayaan akan lebih efektif bila dilakukan dari tatanan rumah tangga, tempat kerja, dan tatanan lain yang telah ada di masyarakat.

e. *Re-Orient Health Service*

Re-Orient Health Service atau menata kembali arah utama pelayanan kesehatan kepada upaya preventif dan promotif serta mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

4. Sasaran Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan memiliki 3 jenis sasaran yaitu primer, sekunder dan tersier. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Sasaran Primer

Sasaran primer meliputi individu yang sehat dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat.

b. Sasaran Sekunder

Sasaran sekunder meliputi para pemuka di masyarakat, baik pemuka informal seperti pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain maupun pemuka formal seperti petugas kesehatan, pejabat pemerintahan dan lain-lain. Organisasi kemasyarakatan dan media massa.

c. Sasaran Tersier

Sasaran tersier meliputi para pembuat kebijakan publik yang membuat peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang di luar kesehatan yang berkaitan serta para penyedia sumber daya (Maulana 2009).

5. Lima Tingkatan Pencegahan dalam Promosi Kesehatan

a. *Health Promotion* (Promosi Kesehatan)

Promosi kesehatan merupakan tahapan yang pertama dan utama pada pencegahan penyakit. Pada promosi kesehatan dibutuhkan penyamaan persepsi bahwa promosi kesehatan merupakan proses yang memberikan informasi kesehatan pada masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kegiatan atau usaha Promosi Kesehatan diantaranya seperti pendidikan kesehatan meliputi peningkatan gizi, kebiasaan hidup, seksual. Perbaikan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air rumah tangga, perbaikan pembuangan sampah, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, hygiene perorangan, rekreasi, perisapan memasuki kehidupan pra nikah dan menopause. Contoh promosi kesehatan antara lain:

- 1) Penyediaan makanan yang sehat dan berkecukupan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- 2) Perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan
- 3) Pendidikan kesehatan pada masyarakat
- 4) Olahraga secara teratur sesuai kemampuan individu
- 5) Kesempatan memperoleh hiburan untuk perkembangan mental dan sosial
- 6) Nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggung jawab

b. *Specific Protection* (Perlindungan Khusus)

Specific Protection atau perlindungan khusus merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat pada ancaman penyakit tertentu. Kegiatan perlindungan khusus meliputi melakukan imunisasi secara spesifik, pemberian makanan khusus, perlindungan dari penyakit alat kerja, perlindungan dari bahan karsinogenik, perlindungan dari zat alergen. Contoh kegiatan perlindungan seperti berikut:

- 1) Melakukan imunisasi lanjutan seperti imunisasi HPV, pendidikan kesehatan, konseling tentang berbagai tema kesehatan
- 2) Melakukan kegiatan kumur dengan larutan flour mencegah karies gigi
- 3) Mencucitangan dengan larutan aspetik mencegah infeksi

c. *Early Diagnosis and Prompt Treatment* (Diagnosis Dini dan Pengobatan Segera)

Early Diagnosis and Prompt Treatment atau diagnosis dini dan Pengobatan Segera merupakan tindakan menemukan penyakit sedini mungkin serta melakukan penatalaksanaan secara segera dengan ketepatan terapi. Contoh kegiatan diagnosis dini dan pengobatan segera antara lain:

- 1) Pemberian tablet Fe dan pengajaran makan makanan yang mengandung zat besi pada ibu hamil yang menunjukkan tanda-tanda anemia
- 2) Melakukan screening di masyarakat dengan pemeriksaan dahak dan rontgen paru untuk penyakit Tuberculosis Paru-paru.
- 3) Melakukan screening orang dengan kontak penyakit menular agar dapat melakukan pengobatan segera
- 4) Melakukan screening untuk mendeteksi dini kanker

d. *Dissability Limitation* (Mengurangi Kecacatan)

Dissability Limitation atau Mengurangi Kecacatan merupakan tindakan penatalaksanaan terapi yang maksimal pada penyakit yang telah lanjut untuk mencegahnya menjadi lebih berat, menjadikan sembuh serta mengurangi kemungkinan kecacatan yang akan timbul.

e. *Rahbilitation* (Rehabilitasi)

Tingkat rehabilitasi merupakan tingkat pencegahan terakhir untuk masyarakat yang sakit dan dapat disembuhkan menjadi sehat pada saat kembali ke masyarakat serta dapat menjalankan hidup seperti semula dengan fungsi yang positif bagi dirinya dan bagi masyarakat lainnya. Rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan fungsinya dimasyarakat dengan tidak menjadi beban untuk individu lain. Seseorang dengan penyakit tertentu dan melakukan tahap pengobatan, terdapat tiga opsi yang pertama adalah sembuh total, sembuh dengan cacat dan tidak sembuh atau meninggal. Contoh tingkat rehabilitasi seperti ketika seseorang mengalami kecelakaan kemudian patah tulang pada tangan, dapat direhabilitasi dengan menggunakan tangan palsu pada tangan yang patah karena memiliki fungsi yang sama. Contoh lainnya yaitu untuk mantan pengguna narkoba harus menjalani rehabilitasi sebelum kembali ke masyarakat.

6. Strategi Promosi Kesehatan

Menurut WHO 1994 dalam Windi 2019 menyatakan bahwa strategi promosi kesehatan terdapat tiga bagian yaitu:

a. *Advocacy* (Advokasi)

Advocacy atau advokasi merupakan upaya untuk menyakinkan orang lain atau orang yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan. Dalam promosi kesehatan, advokasi merupakan upaya pendekatan pada para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di berbagai tingkatan dan bagian. Adanya upaya pendekatan tersebut, para pembuat kebijakan atau keputusan diharapkan dapat mendukung program kesehatan yang akan dilaksanakan. Bentuk-bentuk dukungan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan,

surat keputusan, instruksi formal, dan lain-lain. Proses advokasi dapat melalui dua cara, yaitu formal dan informal.

Upaya formal dapat berupa presentasi atau seminar yang memaparkan tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, maupun pemaparan latar belakang program yang telah kita rencanakan. Selain upaya formal, upaya informal juga dapat dilakukan seperti mengadakan pertemuan maupun kunjungan pada para tokoh yang berhubungan langsung dengan program yang akan kita laksanakan. Selain memperoleh dukungan administratif dalam arti kebijakan, dukungan dana dan fasilitas pun dapat kita usulkan untuk mendapatkan dukungan.

b. *Social Support* (Dukungan Sosial)

Strategi dukungan sosial merupakan upaya untuk mencari dukungan sosial melalui beberapa tokoh yang sudah ada di masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan dari dukungan sosial adalah membuat tokoh masyarakat tersebut menjadi tali jembatan yang menghubungkan sektor kesehatan dengan penerima program kesehatan dalam arti masyarakat. Melalui tokoh masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat mau dan mampu menerima pengenalan atau sosialisasi segala program kesehatan yang akan diberikan.

Ukuran kesuksesan upaya dukungan sosial adalah dengan adanya partisipasi dari tokoh masyarakat dan masyarakat khususnya. Dukungan sosial ini dapat dikatakan adalah dalam rangka membina suasana yang kondusif untuk dapat menerima program kesehatan. Bentuk dukungan sosial diantaranya pelatihan tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, maupun bimbingan pada kader kesehatan. Sasaran dari dukungan sosial adalah seluruh tingkatan sosial yang ada di masyarakat tersebut.

c. *Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat)

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya promosi kesehatan yang berfokus pada masyarakat langsung. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemampuan masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu proses membuat orang mampu meningkatkan control lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka, dengan tujuan untuk memobilisasi individu dan kelompok rentan dengan memperkuat keterampilan dasar hidup mereka serta meningkatkan pengaruh mereka pada hal-hal yang mendasari kondisi sosial dan ekonomi (WHO, 2008).

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok

maupun masyarakat secara terencana, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Departemen Kesehatan RI, 2009). Tujuan yang mendasar dari pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menurut WHO adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.

Berbagai bentuk pemberdayaan di masyarakat dapat diwujudkan melalui beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi seperti sistem koperasi, pelatihan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Peningkatan sektor ekonomi akan berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatan mereka. Dampak tersebut dapat terwujud dalam bentuk pos obat desa, Polindes, dan lain-lain

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Media sosial merupakan alat yang efektif dalam upaya promosi kesehatan yang dilakukan rumah sakit. Mengetahui jumlah pengguna aktif platform media sosial tertentu menjadi penting bagi rumah sakit agar penyebaran informasi dan konten promosi kesehatan lebih luas diakses masyarakat. Selain itu, beragam strategi promosi kesehatan yang menarik dan unik dapat meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat terhadap informasi dan konten promosi kesehatan rumah sakit.

Media sosial merupakan media untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar individu menggunakan alat dan jaringan internet. Beberapa definisi tentang media sosial fokus pada penggunaan teknologi oleh media sosial, dan hal tersebut yang membedakannya dengan media sosialisasi tradisional. Kaplan & Haenlein (2010) menyatakan bahwa media sosial merupakan jenis aplikasi berbasis teknologi internet dan website.

Selain itu, McGowan et al., (2012) mengartikan media sosial sebagai lingkungan online di mana pengguna dapat berkontribusi pada konten dan mengonsumsi konten yang sebagian besar dihasilkan oleh pengguna lain.

Beberapa definisi tentang media sosial juga menekankan bahwa adanya konten yang dibuat oleh pengguna merupakan fitur penting yang membedakan media sosial dari media tradisional. Berkaitan dengan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat, tujuan kesehatan mencakup promosi kesehatan, layanan medis dan administrasi, penelitian kesehatan, pendidikan dan pelatihan medis, dan gerakan sosial yang berhubungan dengan kesehatan (Vasthu Broto Ariyo & Achadi, 2022).

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jadi, media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia.

Di Era digital yang dikenal dengan Web 2.0 atau Health 2.0 atau Medicine 2.0 menjadikan masyarakat sehat dan pasien lebih mengandalkan internet daripada dokter sebagai sumber informasi perawatan kesehatan. Situs web media sosial yang populer terbukti efektif dan ampuh untuk menyebarluaskan informasi kesehatan, mendukung upaya promosi kesehatan dan dapat ditelusuri secara online seperti YouTube, Facebook, MySpace, Twitter, dan Second Life serta image sharing, mobile technology dan blog. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan kegiatan promosi kesehatan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari melalui media Twitter, Facebook, Instagram, Youtube yang berisi konten kesehatan berupa foto, video, dan poster.

Media sosial juga merupakan platform yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini terutama untuk berinteraksi, mendapatkan dan berbagi informasi secara luas dan cepat dengan menggunakan suatu teknologi yang difasilitasi jaringan internet. Pada saat ini media sosial telah menjadi hal yang lumrah bagi setiap orang, hal tersebut menjadikan semakin banyak media sosial baru yang bermunculan, menjadikan masyarakat bebas memilih media sosial mana yang ingin digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, salah-satunya untuk memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Chris Heuer dalam penggunaan media sosial terdapat komponen 4C diantaranya (Solis, 2010:263):

- a. *Context* ialah bagaimana membentuk atau membingkai pesan atau cerita.
- b. *Communication* ialah kegiatan membagikan suatu cerita dan aktivitas interaktif termasuk mendengarkan, menanggapi, dan berkembang.
- c. *Collaboration* ialah fasilitasi dan agregasi atau pengumpulan tindakan hasil kolektif melalui interaksi atau percakapan (*conversation*), kreasi kerjasama (*co-creation*) dan aksi kolektif (*collective*).
- d. *Connection* ialah menjaga hubungan yang kita bina dan jaga secara berkelanjutan untuk membuat pengguna media merasa lebih dekat dengan sebuah media.

Peneliti agnes & Ira 2021 menghadirkan media sosial dalam landasan teori penelitian ini, dimaksudkan sebagai fondasi atau dasar dalam meneliti penggunaan media sosial yaitu media sosial Instagram. Komponen 4C Chris Heuer biasanya digunakan terkait pembahasan media sosial, khususnya mengenai penggunaan dan akses media sosial.

Sedangkan Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran usergenerated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk sosial network, forum internet, weblogs, sosial blogs, micro blogging, wiki, podcasts, gambar, video, rating dan bookmark sosial. (Lesmana, 2012:10).

Akan tetapi Media sosial merupakan situs dimana setiap orang disediakan fasilitas untuk mengelola web yang sifatnya personal, kemudian terhubung dengan orang lainnya untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Di dalam media sosial seperti Facebook, Youtube, dan Twitter dimana content-nya dikelola sendiri, setiap orang berhak memposting apa yang menurut mereka dianggap penting kepada orang lain.

Sedangkan Menurut Puntodi (2011:1), media sosial merupakan fitur berbasis Website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Path, Youtube, Google+ dan lain-lain.

2. Ciri-Ciri Media Sosial

Media sosial dipahami sebagai jenis media online baru yang unik dan berbeda dengan media-media yang lainnya. Menurut Nasrullah (2015:43) media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Partisipasi.
- b. Keterbukaan.
- c. Percakapan.
- d. Komunitas.
- e. Keterhubungan.

3. Jenis-jenis Media Sosial

Ada banyak sumber, terutama liputan media maupun kajian literatur, yang membagi jenis media sosial. Ada yang berdasarkan model jaringan yang terbentuk, berdasarkan karakteristik penggunaannya, sampai berdasarkan pada file atau berkas apa saja yang disebar (sharing) di antara pengguna. Nasrullah (2015:39) menyimpulkan bahwa setidaknya ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, pembagian jenis media sosial ke dalam kategori ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana jenis media sosial itu. Keenam kategori itu, yakni :

- a. Sosial *Networking*
- b. Blog
- c. *Microblogging*
- d. Media *Sharing*
- e. Sosial *Bookmarking*
- f. Wiki

Media sosial merupakan upaya dalam berbagi informasi yang mudah bagi masyarakat

- a. *Social networking*,

Merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Contohnya Facebook, Twitter, dan LinkedIn.

- b. Media sharing networks, yaitu media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi foto dan video. Contohnya Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok.
- c. Discussion forums, yaitu media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk berdiskusi dan bertukar opini. Contohnya Quora, Reddit, dan Kaskus.
- d. Social blogging networks, yaitu media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mempublikasikan konten. Contohnya Tumblr dan Medium.
- e. Social audio networks, yaitu media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi melalui suara. Contohnya *Clubhouse*, *Twitter Spaces*, *Discord*, *Spotify Greenroom*, dan Facebook *Live Audio Rooms*.

- f. Live stream social media, yaitu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan siaran langsung. Contohnya Twitch dan YouTube.
- g. Review networks, yaitu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk memberikan ulasan tentang produk, layanan, atau pengalaman bekerja. Contohnya Yelp dan Glassdoor.

Melalui macam-macam media sosial inilah dapat mempermudah melakukan promosi kesehatan.

D. Hambatan dalam mengakses promosi sosial melalui media sosial

Hambatan dalam mengakses promosi sosial melalui media sosial bisa berupa gangguan jaringan, kesibukan pribadi, dan informasi yang tersebar. Berikut beberapa hambatan dalam mengakses promosi sosial melalui media sosial: Gangguan jaringan atau koneksi internet, Kesibukan pribadi, Informasi yang tersebar di berbagai platform, Banyak orang yang enggan mencampur pengalaman berbelanja dengan aktivitas jejaring sosial.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- a. Memiliki kehadiran yang kuat di beberapa platform media sosial yang relevan
- b. Memastikan konsistensi konten yang disajikan
- c. Tidak hanya menggunakan satu platform media sosial
- d. Memberikan informasi secara lengkap dan detail
- e. Memahami target audience
- f. Menggunakan media sosial secara efektif

Beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan media sosial marketing diantaranya yaitu,

- a. Kegagalan dalam memahami media sosial

Salah satu masalah yang seringkali muncul disebabkan karena adanya pemahaman yang salah ketika memulai strategi ini. Masalah ini menjadi besar ketika kesalahpahaman tersebut masih tetap tertanam, sehingga yang seringkali dilakukan adalah terus menerus melakukan promosi, yang pada akhirnya pesan yang Anda kirimkan ditandai sebagai spam.

- b. Kurangnya pemahaman tentang media sosial marketing

Karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh para pelaku bisnis online (khususnya bagi yang sedang menerapkan media sosial marketing) membuat banyak pemilik bisnis hanya asal dan sembarangan melakukan promosi di media sosial. Padahal untuk memperoleh keberhasilan dalam strategi ini tetap saja dibutuhkan pengetahuan khusus yang akan mengantarkan pelaku bisnis online untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan.

c. Lambatnya jaringan internet

Media sosial yang membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya terkadang menjadi masalah tersendiri. Karena kenyataannya penyebaran internet yang cepat belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar tentunya hal tersebut tidak akan begitu menjadi masalah. Lain halnya dengan orang-orang yang berada di wilayah-wilayah yang minim jaringan internet, sehingga pada akhirnya kendala jaringan internet ini menjadi masalah yang cukup serius dalam penerapan media sosial marketing.

d. Tidak adanya orang yang mengelola media sosial

Seringkali pekerjaan mengelola media sosial dianggap sepele sehingga akhirnya tidak ada orang yang khusus menganganinya. Jika masalah ini dibiarkan maka jangan heran jika pada akhirnya banyak hasil yang kurang optimal dalam menjalankan media sosial marketing. Terlebih lagi karena bisnis yang dijalankan masih kecil, membuat banyak orang tidak mampu membayar orang untuk mengelola media sosial yang digunakan untuk alat promosi.

E. Simpulan

Dengan Kemajuan teknologi pada era 4.0 dengan fokus *internet of things* tentunya sangat berpengaruh dan menjadi komponen penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal komunikasi, seperti yang dikemukakan McLuhan (1962:326) "*Technology has changed the way we communicate*" yang memiliki arti bahwa teknologi lah yang merubah cara kita (manusia) berkomunikasi. Menurut Ruben dan Steward (1998:16) komunikasi sendiri adalah suatu proses komunikator baik individu atau kelompok menciptakan atau membagikan informasi agar mencapai tujuan saling pengertian antara komunikator dan komunikan. Internet memudahkan penggunaanya untuk melakukan akses dimana saja dan kapan saja melalui smartphone atau perangkat lain guna mempermudah pekerjaan manusia baik dalam hal berkomunikasi, mencari dan mendapatkan serta berbagi informasi. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Rudiantara (2017:1), saat ini telah terjadi perubahan pada era komunikasi, internet khususnya media sosial telah banyak digunakan sebagai jalur komunikasi, penggunaannya didukung secara masif terutama pada lembaga pemerintahan daerah sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Saat ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, hampir seluruh kementrian dan lembaga khususnya pemerintah daerah memiliki media sosial untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, kebijakan dan capaian-capaiannya (Heriani, 2019:1).

Berdasarkan data dari Websindo.com pada Januari 2019 tercatat ada 150 juta pengguna internet aktif di Indonesia dari total penduduk Indonesia sebanyak 268,2

juta jiwa atau 56% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Selain itu, hampir keseluruhan pengguna internet merupakan pengguna aktif media sosial dengan jumlah penggunanya mencapai 56% dari total populasi penduduk Indonesia yang artinya lebih dari setengah penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial saat ini sudah semakin marak, salah satunya adalah media sosial Instagram (Amira & Nurhayati, 2019:117).

Media sosial menurut Hidayatullah (2020:1) ialah situs atau layanan daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengonsumsi serta mengikuti atau berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan berbagai konten dalam berbagai format seperti teks, gambar, video dan foto. Instagram sendiri merupakan media sosial yang digunakan oleh para penggunanya sebagai media sosial dengan fungsi membagikan informasi berupa gambar, foto, video dan caption Atmoko (2012:28), karena itu Instagram dikategorikan sebagai media sosial. Instagram dijadikan sebagai objek penelitian pada penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya sejak diluncurkan pada tahun 2010 pertumbuhan media sosial Instagram dapat dikatakan berjalan dengan cepat dan pesat. Menurut Direktur Facebook Indonesia (dalam Adi & Hidayat, 2017:1) kurang lebih 45 juta orang di Indonesia menggunakan Instagram secara aktif, Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik, dan menjadi salah satu pengguna terbesar di dunia dari total 700 juta pengguna aktif setiap bulannya. Padahal, pengguna aktif di awal tahun 2016 hanya 22 juta.

Saat ini, media sosial Instagram tidak hanya digunakan oleh individu tetapi juga dapat digunakan oleh kelompok, komunitas, organisasi, perusahaan bahkan hingga pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018:11-15) pemerintah memiliki konsen mengenai pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah sebagai salah satu inovasi dalam memaksimalkan teknologi. Seperti digunakan sebagai media penyebaran informasi seputar suatu kota atau kabupaten oleh pemerintah kota atau kabupaten tersebut. Ini menunjukkan media sosial Instagram tidak hanya merupakan media yang digunakan untuk mengekspresikan diri tetapi juga digunakan sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan pengguna internet terbesar di Indonesia, yaitu pada tahun 2018 kontribusinya mencapai 16% dari total pengguna internet Indonesia yang mencapai 171,17 juta jiwa (Rachmawati, 2019:1).

F. Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Cahyono, Anang Sugeng. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN : 1979 – 0295. Universitas Tulungagung.
- Glanz, K, K. Rimer, B & Viswanath, K (2008). *Health Behavior And Health* Glanz, K., Rimer, B.K., Lewis. 2002. *Health Behavior and Helath Education: Theory, research, and Practice*. Edisiketiga. San Fancisco: Jossey Bass publisher.
- Green, W, Lawrence.et.al. 2005. *Helath Education Planing A Diagnostik Approach*, The Johns Hapkins University: Mayfield Publishing Company
- Helen dan Rusdi, F. (2018). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Akun Instagram @Jktinfo Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers. *Prologia*, Vol. 2, No. 2, 359. <https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3712>.
- Heriani F.N. (2019). Peran Medsos dalam Keterbukaan Informasi di Kementerian dan Lembaga. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8bf37a77904/peranmedsos-dalam-keterbukaaninformasi-di-kementerian-danlembaga/>
- Jurnal Common | Volume 5 Nomor 2 | Desember 2021 Website:
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common> DOI Jurnal:
<https://doi.org/10.34010/common> DOI Artikel:
<https://doi.org/10.34010/common.v5i2.5143>
- Maulana, Heri, d.j. 2009. *Promosi Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran: EGC.
- Syarifudin. 2009. *Promosi Kesehatan untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: TIM
- Windi Chusniah Rachmawati, S,KM., M.Kes.2019. *PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU*.Penerbit Wineka Media.

G. Glosarium

WHO = *World Health Organization*
HPV= *Human Papillomavirus*

CHAPTER 3

KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PROMOSI KESEHATAN

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

A. Pendahuluan

Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat, dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes RI, 2020). Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (KemenSetNeg, 2023), untuk menuju sehat tersebut dibutuhkan upaya kesehatan, yakni segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah upaya dalam bentuk promotif untuk menuju hidup sehat, yang bebas dari masalah baik secara fisik ataupun mental, karena menjalani hidup yang sehat dan bersih sangat penting, dimulai dari diri sendiri, dengan meninggalkan perilaku buruk atau tidak menunjang kesehatan.

Pemerintah juga tak tinggal diam, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengajak masyarakat hidup sehat adalah dengan melakukan promosi kesehatan, secara terus menerus berupa sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan tujuan untuk meningkatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan GERMAS agar dapat mewujudkan Indonesia yang sehat. (Junita, Handayani, & Alfiah, 2020).

Promosi kesehatan memiliki pengaruh sangat penting dalam upaya penerapan hidup sehat. Promosi kesehatan berdampak pada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan melalui pendidikan, kesadaran, dan perubahan perilaku. Promosi kesehatan memiliki manfaat jangka panjang dalam menurunkan beban penyakit, meningkatkan sistem perawatan kesehatan, dan membina masyarakat yang lebih sehat dan lebih berdaya dengan meningkatkan kesadaran akan nilai kesehatan dan mendorong penerapan perilaku sehat. Untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup, inisiatif promosi kesehatan

perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang tepat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu dan pemerintah, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. (Kemenkes RI, 2020).

Kolaborasi dalam promosi kesehatan sangat penting karena memerlukan pendekatan multidisipliner. Kesehatan merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kolaborasi memungkinkan penggabungan sumber daya, baik itu finansial, manusia, maupun material. Dengan bekerja sama, organisasi dan individu dapat memaksimalkan potensi yang ada dan mencapai lebih banyak daripada jika mereka bekerja sendiri. Melalui kolaborasi, program promosi kesehatan dapat menjangkau lebih banyak orang, misalnya bekerja sama dengan komunitas lokal atau organisasi non-pemerintah dapat membantu menjangkau kelompok yang mungkin tidak terlayani oleh layanan kesehatan tradisional. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan dan memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, kolaborasi dapat menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Kemenkes RI, 2019).

Kolaborasi memungkinkan evaluasi bersama dari program-program yang telah dilaksanakan, sehingga semua pihak dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan efektivitas promosi kesehatan di masa depan. Dengan demikian, kolaborasi dalam promosi kesehatan tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

B. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan

1. Pengertian Kolaborasi

Secara garis besar, kolaborasi dan kerja sama tidak ada perbedaan. Kolaborasi dan kerja sama adalah usaha yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Namun, hubungan maupun interaksi setiap orang atau kelompok yang melakukan kolaborasi dengan pihak lain biasanya lebih intens, sedangkan dalam melakukan kerja sama biasanya cenderung fokus terhadap tugas masing-masing. (Noorsyamsa, 2018).

Konsep kolaborasi mengacu pada kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia kesehatan, kolaborasi dapat membantu pemerintah untuk memperluas sasaran, meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang positif terhadap kesehatan. Dalam kolaborasi, setiap individu membawa keahlian, ide, dan perspektif unik mereka, yang dapat

memperkaya hasil akhir. Konsep ini sangat penting dalam kesehatan, karena dapat meningkatkan kreativitas, efisiensi, dan inovasi gaya hidup sehat. Kolaborasi juga melibatkan komunikasi yang baik, saling menghormati, dan kemampuan untuk mendengarkan serta memahami pandangan orang lain. (Lai, Emily R. 2021). Dengan kolaborasi yang efektif, tim dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih memuaskan.

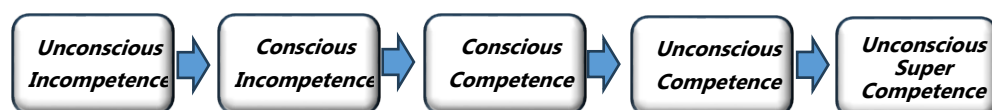
Kolaborasi dalam promosi kesehatan merujuk pada kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi, berbagai sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dapat digabungkan untuk merancang dan melaksanakan program-program kesehatan yang lebih efektif. Kolaborasi menjadi hal yang penting, karena masalah kesehatan seringkali kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan berkolaborasi, berbagai pihak dapat saling mendukung, berbagi informasi, dan menciptakan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. (Dorisman, dkk, 2021).

2. Tujuan Kolaborasi

Kolaborasi dalam promosi kesehatan sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Tujuan kolaborasi dalam promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program-program kesehatan. Dengan kolaborasi, berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian mereka, sehingga dapat membantu dalam: (Kemenkes RI, 2019).

a. Meningkatkan Kesadaran

Kolaborasi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif mengenai isu-isu kesehatan. Kesadaran digambarkan sebagai keadaan mental yang berisi dengan hal-hal pro-posisional, seperti misalnya keyakinan, harapan, kekhawatiran, dan keinginan. Tahapan kesadaran seseorang digambarkan sebagai berikut: (Geller, 2016)



Gambar 3.1 Tahapan kesadaran seseorang (Geller, 2010)

Tahapan kesadaran seseorang dikenal sebagai lima tahapan kesadaran. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana seseorang belajar dan berkembang dalam keterampilan atau kesadaran keselamatan dalam

lingkungannya termasuk terhadap perilaku kesehatan. (Geller, 2016). Berikut penjelasan tahapan tersebut:

1) *Unconscious Incompetence* (Tidak Sadar dan Tidak Kompeten)

Pada tahap ini individu tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kekurangan dalam keterampilan atau pengetahuan tertentu serta tidak memahami bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.

2) *Conscious Incompetence* (Sadar tetapi Tidak Kompeten)

Pada tahap ini individu mulai menyadari kekurangannya, tetapi belum mampu melakukan perubahan, dan telah memahami bahwa ada keterampilan atau pengetahuan yang perlu dipelajari.

3) *Conscious Competence* (Sadar dan Kompeten)

Pada tahap ini Individu telah memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan, tetapi masih harus berpikir secara sadar untuk menggunakannya. Proses ini membutuhkan usaha dan perhatian penuh.

4) *Unconscious Competence* (Tidak Sadar tetapi Kompeten)

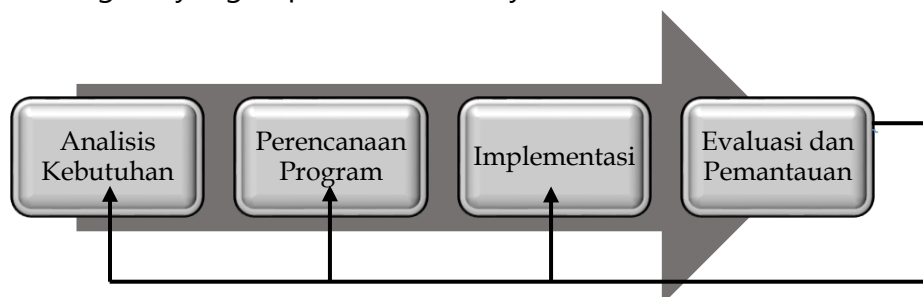
Pada tahap ini individu dapat melakukan keterampilan atau tugas tertentu secara otomatis tanpa perlu berpikir secara sadar. Contohnya adalah seseorang yang telah mahir dalam mengemudi sehingga melakukannya tanpa berpikir banyak.

5) *Unconscious Super Competence* (Tidak Sadar tetapi Sangat Kompeten)

Tahapan ini merupakan tahapan tertinggi, dimana individu tidak hanya kompeten secara otomatis, tetapi juga mampu mengajarkan dan mempengaruhi orang lain. Biasanya dimiliki oleh para ahli di bidangnya yang dapat beradaptasi dalam berbagai situasi.

b. Menciptakan Program yang Komprehensif

Menciptakan program promosi kesehatan yang komprehensif memerlukan pendekatan terstruktur yang mencakup beberapa langkah penting. Berikut adalah langkah yang dapat diikuti: (Cahyarini A, 2024).



Gambar 3.2 Langkah Menciptakan Program Komprehensif

1) Analisis Kebutuhan

Identifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau kelompok sasaran. Hal ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, atau metode lain untuk memahami kebutuhan dan prioritas kesehatan mereka.

2) Perencanaan Program

Berdasarkan analisis kebutuhan, tetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Pilih strategi dan metode intervensi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

3) Implementasi

Laksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dan sumber daya yang diperlukan tersedia.

4) Evaluasi dan Pemantauan

Lakukan pantauan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Gunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian program agar lebih efektif.

c. Memperkuat Jaringan

Memperkuat jaringan kolaborasi dalam promosi kesehatan memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan sektor. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan: (Nurmala, dkk, 2018)



Gambar 3.3 Jaringan Kolaborasi dalam Promosi Kesehatan

1) Kolaborasi Lintas Sektor

Membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam promosi kesehatan. Sinergi ini memungkinkan

pemanfaatan sumber daya dan keahlian yang beragam untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat.

2) Pemanfaatan Media Sosial dan Teknologi Informasi

Menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan kesehatan secara kreatif dan edukatif dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas promosi kesehatan. Media sosial memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara pemberi informasi dan masyarakat.

3) Pendidikan Antar Profesi (*Inter Professional Education/IPE*)

Menerapkan IPE dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan dapat meningkatkan keterampilan kerjasama tim dan pemahaman lintas profesi, yang pada gilirannya memperkuat kolaborasi praktik promosi kesehatan.

4) Pengembangan Jaringan Kemitraan

Membangun kemitraan dengan organisasi yang memiliki sumber daya dan keahlian yang saling melengkapi dapat memperkuat upaya promosi kesehatan. Hal ini mencakup berbagi sumber daya, pengetahuan, dan strategi untuk mencapai tujuan bersama.

5) Integrasi Program dengan Kegiatan Masyarakat Lokal

Mengintegrasikan program promosi kesehatan dengan kegiatan masyarakat, seperti posyandu atau karang taruna, dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program. Pendekatan ini memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

6) Advokasi dan Penggunaan Media Massa

Menggunakan media massa untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu kesehatan dapat memperkuat jejaring dan kegiatan advokasi yang dilakukan. Media memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik dan pengambil keputusan terkait kebijakan kesehatan.

Dengan menerapkan kegiatan di atas, diharapkan jaringan kolaborasi dalam promosi kesehatan dapat diperkuat, sehingga upaya peningkatan kesehatan masyarakat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

d. Mengoptimalkan Sumber Daya

Dengan berbagi sumber daya, biaya dapat ditekan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai. Sumber daya dalam promosi kesehatan meliputi sumber daya manusia (SDM), harapan, dan media komunikasi. Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005).

1) Sumber daya manusia (SDM)

SDM kesehatan adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal maupun tidak. SDM kesehatan merupakan input penting dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan.

2) Harapan

Harapan merupakan sumber daya yang penting untuk promosi kesehatan, baik bagi orang yang sehat maupun yang sakit. Harapan dapat difasilitasi dengan komunikasi atau interaksi perawat-pasien.

3) Media komunikasi

Media komunikasi yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan meliputi media cetak, media elektronik, dan media sosial. Media cetak seperti koran, majalah, dan buku. Media elektronik seperti radio dan televisi. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Linked In.

e. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Kolaborasi melibatkan masyarakat secara langsung, yang meningkatkan partisipasi dan kepemilikan terhadap program kesehatan. Meronda M (2021) mengatakan terdapat empat indikator yang mencakup partisipasi masyarakat, yaitu:

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang dilakukan, bilamana akan melakukan dan siapa yang akan melakukan.

Adapun urutan bagian-bagian perencanaan yang merupakan sistematis berfikir dalam perencanaan yang meliputi:

a) Hasil akhir (*the ends*)

Spesifikasi dari tujuan atau sasaran, target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya.

b) Alat-alat (*the means*)

Meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur, dan praktiknya. Disini menentukan bagaimana rencana disusun.

c) Sumber-sumber (*the resources*)

Meliputi kuantitas, pendapatan, dan pengalokasian beberapa sumber, seperti tenaga kerja, keuangan, material, tanah, dan lain sebagainya.

d) Pelaksanaan (*Implementation*)

Menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya, sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan.

e) Pengawasan (*control*)

Menentukan prosedur yang akan dilaksanakan jika ditemukan kesalahan, kegagalan dari rencana, dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan selanjutnya.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun. Bentuk partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil.

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaannya untuk memanfaatkan hasil, misalnya, memanfaatkan hasil musyararah untuk menyelenggarakan posyandu untuk seluruh siklus, dan hasilnya atau posyandu tersebut dimanfaatkan secara maksimal.

3. Nilai-Nilai Dasar dalam Kolaborasi

Terdapat sejumlah nilai yang menjadi dasar dalam melaksanakan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut akan menjadi pegangan untuk kolaborator, sehingga tujuan bersama dapat diraih. Terdapat tujuh nilai dasar (*The seven core values*) yang dilakukan guna meningkatkan kolaborasi (Djumara, 2018), yaitu:

a. Menghormati orang lain (*Respect for people*)

Landasan utama dari setiap kegiatan adalah kepuasan masing-masing orang. Setiap orang yang akan berkolaborasi mengharapkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka mengharapkan kepuasan pribadi yang tinggi dan lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan atas dirinya.

b. Penghargaan dan integritas (*Honor and integrity*)

Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan etos kerja. Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk tingkah laku individu.

- c. Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*)
 Saat semua masyarakat memiliki kesehatannya dengan baik atas upaya yang dilakukannya, maka mereka akan memelihara terus kesehatannya dengan baik.
- d. Konsensus (*consensus*)
 Adalah kesepakatan bahwa kegunaan yang sangat besar adalah interaksi semuanya dilandasi oleh keinginan dalam mencapai tujuan.
- e. Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*).
 Rasa tanggung jawab dan tanggung gugat seseorang dalam kesehatannya sangat penting untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Rasa tanggung jawab dalam kesehatan berarti seseorang menyadari dan menjalankan kewajibannya untuk menjaga kesehatannya sendiri. Rasa tanggung gugat berkaitan dengan akuntabilitas seseorang terhadap dampak kesehatannya terhadap orang lain atau lingkungan, seperti, jika seseorang dengan sadar mengabaikan protokol kesehatan dan menyebabkan orang lain tertular penyakit, ia dapat dianggap tidak bertanggung gugat.
- f. Hubungan saling mempercayai (*Trust-based Relationship*)
 Semua manusia mengharapkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam berkolaborasi. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya, akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudah. Pada kenyataannya, banyak diantara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai, dan hal inilah yang menyulitkan dalam mencapai tujuan kolaborasi.
- g. Pengakuan dan pertumbuhan (*Recognition and Growth*)
 Hal yang penting dalam promosi kesehatan yang kolaboratif, yaitu adanya upaya mendorong orang untuk berperilaku sehat, dan segera memberi pengakuan terhadap upaya yang dilakukannya.

4. Strategi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Promosi Kesehatan

Strategi kolaborasi sangat penting untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Dengan menerapkan strategi kolaborasi, diharapkan promosi kesehatan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat Notoatmodjo S (2012) & Nurbadlina, dkk (2021). Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:

- a. Kemitraan Multisektoral
 Menggandeng berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi untuk menciptakan program yang komprehensif. Misalnya, kolaborasi antara dinas kesehatan dan sekolah untuk mengedukasi siswa tentang pola hidup sehat.

b. Keterlibatan Komunitas

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program promosi kesehatan. Ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, pelatihan, atau kegiatan komunitas yang mendorong partisipasi aktif.

c. Penggunaan Media Sosial

Memanfaatkan *platform* media sosial untuk menyebarkan informasi kesehatan secara luas dan cepat. Kolaborasi dengan *influencer* atau tokoh masyarakat dapat meningkatkan jangkauan pesan.

d. Program Edukasi Bersama

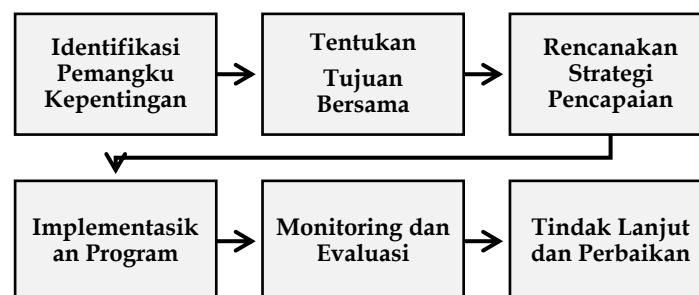
Mengadakan seminar, workshop, atau kampanye kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

e. Penelitian dan Pengembangan

Bekerja sama dengan institusi akademis untuk melakukan penelitian yang dapat mendukung program promosi kesehatan dan memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.

5. Langkah-Langkah Kolaborasi dalam Promosi Kesehatan

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kolaborasi dalam promosi kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat. (Susilowati, I., & Purnamasari, D, 2021)., sebagai berikut:



Gambar 3.4 Langkah-Langkah Kolaborasi dalam Promosi Kesehatan

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Temukan dan libatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta.

a. Tentukan Tujuan Bersama

Diskusikan dan tetapkan tujuan promosi kesehatan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Pastikan semua pihak memiliki visi yang sama.

b. Rencanakan Strategi

Buat rencana aksi yang jelas, termasuk strategi dan metode promosi yang akan digunakan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan.

c. Implementasi Program

Laksanakan program promosi kesehatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pastikan semua pihak berkontribusi sesuai peran masing-masing.

d. Monitoring dan Evaluasi

Lakukan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Kumpulkan data dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat.

e. Tindak Lanjut dan Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan program promosi kesehatan di masa mendatang.

6. Indikator Keberhasilan Kolaborasi Lintas Sektor dan Faktor yang mempengaruhinya

a. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan mencerminkan sejauh mana kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan mencapai tujuan yang diinginkan. (Suratman, dkk, 2023). Berikut adalah beberapa indikator utama:

1) Komitmen dan Partisipasi Aktif

Semua pihak yang terlibat menunjukkan komitmen dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Adanya keterlibatan aktif dari pemerintah, organisasi kesehatan, komunitas, akademisi, dan sektor swasta.

2) Komunikasi yang Efektif

Terdapat saluran komunikasi yang jelas antara mitra kolaborasi. Transparansi dalam berbagi informasi dan pengambilan keputusan.

3) Sumber Daya yang Memadai

Ketersediaan dana, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan program. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

4) Sinergi dalam Perencanaan dan Implementasi

Program yang disusun berbasis bukti dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan intervensi kesehatan.

5) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Adanya pelatihan atau peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap isu kesehatan yang dipromosikan.

6) Dampak Positif pada Kesehatan Masyarakat

Penurunan angka kejadian penyakit yang menjadi fokus promosi kesehatan. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku sehat di masyarakat.

7) Keberlanjutan Program

Program dapat terus berjalan meskipun ada perubahan kepemimpinan atau kebijakan. Masyarakat dan pemangku kepentingan tetap mendukung program dalam jangka panjang.

8) Evaluasi dan Pemantauan yang Berkelanjutan

Adanya mekanisme pengukuran efektivitas program secara berkala. Program diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

b. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kolaborasi

Keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan penting. (Barbara Gray, 1989) :



Gambar 3.5 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kolaborasi

1) Komunikasi Efektif

Komunikasi yang jelas dan efektif antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi promosi kesehatan. Komunikasi efektif memiliki peran krusial dalam keberhasilan kolaborasi karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami tujuan bersama, berbagi informasi dengan jelas, serta mengatasi tantangan dengan lebih efisien. Dengan komunikasi efektif, maka:

a) Meminimalkan Kesalahpahaman

Komunikasi yang jelas dan terbuka mengurangi risiko miskomunikasi yang dapat menghambat kerja sama dalam tim.

b) Meningkatkan Kepercayaan dan Hubungan

Komunikasi yang baik menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan mendukung, sehingga membangun rasa saling percaya antar anggota tim.

c) Memperjelas Peran dan Tanggung Jawab

Dalam kolaborasi, setiap anggota tim perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan lancar dan efektif.

d) Mendorong Inovasi dan Kreativitas

Komunikasi yang terbuka memungkinkan pertukaran ide dan masukan yang lebih baik, yang dapat menghasilkan solusi inovatif.

e) Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas

Dengan komunikasi yang efektif, proses kerja menjadi lebih lancar, menghindari keterlambatan akibat ketidakjelasan instruksi atau informasi yang tidak tersampaikan.

f) Memudahkan Penyelesaian Konflik

Dalam kerja sama, konflik tidak bisa dihindari. Namun, komunikasi yang baik memungkinkan diskusi yang konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang positif.

2) Komitmen dan Kerja Sama

Komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam implementasi program promosi kesehatan. Ketika komitmen dan kerja sama berjalan beriringan, kolaborasi dalam promosi kesehatan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Komitmen mencerminkan dedikasi dan tekad dari setiap individu atau organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks promosi kesehatan, komitmen yang kuat memastikan bahwa semua pihak tetap fokus pada tujuan jangka panjang, menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan konsisten, serta bersedia mengatasi tantangan yang muncul. Tanpa komitmen, inisiatif kolaboratif dapat terhenti atau kehilangan arah. (Robbins, S. P., & Judge, T. A., 2019).

Kerja sama melibatkan interaksi dan sinergi antara berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-profit. Dengan kerja sama yang baik, setiap pihak dapat berbagi sumber daya, keahlian, dan informasi untuk menciptakan strategi promosi kesehatan yang lebih efektif. Kerja sama juga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program serta memperkuat dukungan sosial yang mendorong perubahan perilaku sehat di masyarakat. (Lai, Emily R., 2021)

3) Variasi Kegiatan Berbasis Masyarakat

Variasi kegiatan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan. Dengan

mengimplementasikan berbagai aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas, program promosi kesehatan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, program "Gempur Stunting" di Puskesmas Rancakalong Sumedang berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 19,8%, di bawah ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20%. (Manggala T, Suminar, & Hafiar.,2021).

Keberhasilan kolaborasi antar sektor terkait, membuahkan kerja sama yang efektif antara berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, memastikan bahwa program berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan serta sustainabilitas program, untuk memastikan bahwa program berjalan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan mengadopsir kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menjalin kolaborasi yang efektif antar sektor, program promosi kesehatan dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

4) Koordinasi Antar Sektor

Koordinasi antar sektor memainkan peran krusial dalam keberhasilan kolaborasi promosi kesehatan. Kerja sama yang efektif antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas, memastikan bahwa program promosi kesehatan dapat diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Indonesia. Germas menekankan pentingnya pendekatan multi sektor untuk menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama dan komitmen bersama antar sektor terkait, yang diwujudkan melalui strategi penguatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat.

Kurangnya koordinasi dapat menjadi hambatan dalam proses pembangunan kesehatan. Ego sektoral, dimana setiap sektor hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sering kali menyebabkan kurangnya kerjasama yang efektif. Hal ini mengakibatkan program kesehatan tidak berjalan optimal dan tujuan kesehatan masyarakat sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, dan bekerjasama antar berbagai pihak. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan. Dengan demikian, promosi kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Secara

keseluruhan, koordinasi antar sektor yang baik memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, menghindari duplikasi, dan mencapai hasil yang lebih efektif dalam promosi kesehatan. (Noorsyamsa., 2018).

5) Sumber Daya yang Memadai

Sumber daya yang memadai memainkan peran penting dalam keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan. Sumber daya ini mencakup tenaga ahli, pendanaan, infrastruktur, teknologi, serta informasi yang akurat dan terkini. Dengan adanya sumber daya yang cukup, setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat menjalankan perannya secara efektif, mulai dari perencanaan hingga implementasi program promosi kesehatan. Ketika sumber daya tersedia, tim dapat lebih mudah mengembangkan strategi yang inovatif, menyebarkan informasi kesehatan secara luas, serta menjangkau kelompok sasaran dengan lebih optimal. Selain itu, dukungan finansial yang cukup memungkinkan penyelenggaraan kegiatan edukasi, kampanye kesehatan, dan penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan. (Meronda, M., 2021).

Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas kolaborasi, menyebabkan kurangnya koordinasi, serta mengurangi jangkauan dan dampak program yang dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memastikan ketersediaan dan distribusi sumber daya yang optimal demi keberhasilan promosi kesehatan yang berkelanjutan.

6) Kepemimpinan yang Kuat

Kepemimpinan yang kuat memainkan peran penting dalam keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan. Pemimpin yang efektif mampu memotivasi, memfasilitasi, dan mendukung tim kesehatan untuk bekerja sama secara sinergis, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks kolaborasi interprofesi, kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Tugas tenaga kesehatan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan keterampilan kolaborasi yang baik agar dapat menangani masalah kesehatan secara kolektif sebagai tim.

Kepemimpinan yang handal dibutuhkan dalam kolaborasi interprofesi, karena setiap anggota terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda sehingga saling tergantung satu sama lain. Selain itu, gaya kepemimpinan demokratis, yang menekankan partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan

keputusan telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja tenaga kesehatan. Pemimpin yang menerapkan gaya ini mendorong diskusi dan penyelesaian masalah secara bersama-sama, sehingga meningkatkan kerja sama tim dan efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan, karena mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengoptimalkan potensi setiap anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. (Kickbusch, I., & Gleicher, D., 2012).

7) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan kolaborasi promosi kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program kesehatan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memungkinkan identifikasi kebutuhan kesehatan yang lebih akurat dan penerapan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, pemberdayaan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan mereka sendiri, yang pada gilirannya memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam promosi kesehatan. Sebagai contoh dalam penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas program promosi kesehatan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan relevansi program tersebut dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Green, L. W., & Kreuter, M.W., 2005).

8) Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan. Program yang dirancang untuk berjalan secara berkelanjutan memastikan bahwa upaya promosi kesehatan tidak hanya bersifat sementara, tetapi terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu faktor kunci dalam mencapai keberlanjutan adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program promosi kesehatan dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan program tersebut.

Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, juga berkontribusi pada keberlanjutan program. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat mempercepat pencapaian tujuan program promosi kesehatan. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, namun jika bekerja bersama-

sama, hasilnya akan lebih optimal. Dengan demikian, memastikan keberlanjutan program melalui partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar sektor adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam promosi kesehatan. Kemenkes RI. (2020).

C. Simpulan

Program promosi kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna meningkatkan efektivitas program kesehatan. Dengan berbagi keahlian, sumber daya, dan informasi, kolaborasi dapat menghasilkan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan melalui peningkatan kesadaran, menciptakan program komprehensif, memperkuat jaringan, mengoptimalkan sumber daya, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kesehatan. Kolaborasi efektif didukung oleh nilai-nilai: menghormati orang lain, penghargaan dan integritas, rasa memiliki, konsensus, tanggung jawab, kepercayaan, serta pengakuan dan pertumbuhan individu. Strategi kolaborasi lintas sektor meliputi: kemitraan multisektoral, keterlibatan komunitas, penggunaan media sosial, program edukasi bersama serta penelitian dan pengembangan. Kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan penting dalam promosi kesehatan guna mencapai hasil promosi kesehatan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Keberhasilan kolaborasi dalam promosi kesehatan dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, sinergi dalam perencanaan dan implementasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta dampak positif pada kesehatan masyarakat. Keberlanjutan program serta evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan juga menjadi faktor penting. Keberhasilan kolaborasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi yang efektif untuk meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi, komitmen dan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta variasi kegiatan berbasis masyarakat yang relevan. Koordinasi antar sektor, kepemimpinan yang kuat, pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya yang memadai juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas program promosi kesehatan.

D. Referensi

Barbara Gray. (1989). *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1989

- Cahyarini A, (2024). *Promosi Kesehatan: Strategi Peningkatan Kesehatan Global*, FK Unisa, Yogyakarta.
- Dooris, M., & Doherty, S. (2010). *Healthy settings: Challenges to generating evidence of effectiveness. Health Promotion International*, 25(3), 262–270. <https://doi.org/10.1093/heapro/daq045>
- Dorisman, Muhammad, & Setiawan. (2021). *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 70 – 83.
- Geller, E. S. (2016). *The Psychology of Safety Handbook. In The Psychology of Safety Handbook*. <https://doi.org/10.1201/9781420032567>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill.
- Guffey, M. E., & Loewy, D. (2021). *Business Communication: Process & Product* (10th ed.). Cengage Learning.
- Heath, C., & Heath, D. (2007). *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. Random House.
- Junita, Handayani, & Alfiah. (2020). *Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Di Desa Rambah Hilir. Jurnal Kumawula*, Vol. 3, No.1, April 2020, Hal 100 – 105 <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/issue/view>
- Kementerian Kesehatan RI (2019). *Buku saku kesehatan kerja lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia sehat*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Promosi Kesehatan di Indonesia*. Kemenkes RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Strategi nasional pembangunan kesehatan 2020–2024*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kementerian Setneg RI, *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta
- Kickbusch, I., & Gleicher, D. (2012). *Governance for health in the 21st century*. World Health Organization.
- Kraut, R. E., & Streeter, L. A. (1995). *Coordination in Software Development*. Communications of the ACM, 38(3), 69–81.
- Lai, Emily R. (2021); *Collaboration: A Literature Review*, h.1–48
- Laverack, G. (2013). *Health activism: Foundations and strategies*. SAGE Publications.
- Lindeke, L., Sieckert, A. M, (2019). *Nurse-Physician Workplace Collaboration, Journal of Issues in Nursing*, 2019.
- Manggala T, Suminar, & Hafiar. (2021), *Faktor-Faktor Keberhasilan Program Promosi Kesehatan “Gempur Stunting” Dalam Penanganan Stunting di Puskesmas*

Rancakalong Sumedang. Journal of Strategic Communication Vol. 11, No. 2, Hal. 88-98 Maret 202. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila

- Meronda, M. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 141–149.
- Noorsyamsa Djumara, (2018). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurbadlina, Shaluhiahb, & Suryoputro. (2021). *Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Jalanan*. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* Vol.12 No.2 (2021) 334-343
- Nurmala dkk. (2018). *Promosi Kesehatan*, cetakan 1, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP), Surabaya
- Nutbeam, D. (2000). *Health Literacy as a Public Health Goal: A Systematic Review*. *Health Promotion International*. 15(3), 259–267. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>
- Rachmawati W. (2019). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Wineka Media, Malang.
- Rasanathan, K., Bennett, S., & Atkins, V. (2017). *Governing multisectoral action for health in low-income and middle-income countries*. *The BMJ*, 358, j3544. <https://doi.org/10.1136/bmj.j3544>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior*, 18th edition. Pearson.
- Suratman, Damayanti, & Azzahla. (2023). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Kolaborasi Interprofesi Dan Lintas Sektor Dalam Intervensi Prioritas Penurunan Stunting Di Wilayah Puskesmas Ujungpangkah*. *Jurnal Ners* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 Halaman 858 – 863. Research & Learning in Nursing Science <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>
- Susilowati, I., & Purnamasari, D. (2021). *Kolaborasi lintas sektor dalam promosi kesehatan di era pandemi COVID-19*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 85–97. <https://doi.org/xxxxxxx>
- Widiastuti, F., & Sari, D. P. (2018). *Peran pemerintah daerah dalam promosi kesehatan berbasis masyarakat*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 7(1), 45–60.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Health Promotion Glossary*.
- World Health Organization. (2016). *The role of the health sector in promoting health and well-being: A contribution to the Health 2020 policy framework*. WHO Regional Office for Europe.

E. Glosarium

Gempur Stunting	: Program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya
GERMAS	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Influencer	: Seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain
IPE	: Inter Profesional Education
Kampanye	: Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi opini publik,
MTBS	: Manajemen Terpadu Balita Sakit
Platform	: Landasan atau dasar, baik secara fisik maupun digital
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMART	: Spesifik Measurable Achievable Relevant Time
Stunting	: Kondisi gagal tumbuh pada anak
WHO	: World Health Organization

CHAPTER 4

PENDEKATAN BUDAYA DALAM PROMOSI KESEHATAN KOMUNITAS

Risna, Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M.

A. Pendahuluan

Promosi kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dapat membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan pola hidup yang lebih sehat, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Promosi kesehatan bukan hanya fokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga mencakup perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga kesehatan mereka. Dengan meningkatkan perilaku hidup sehat, promosi kesehatan dapat menurunkan angka kejadian penyakit, memperpanjang umur harapan hidup, serta mengurangi beban biaya kesehatan secara keseluruhan (Nutbeam, 2019).

Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku kesehatan masyarakat. Dalam banyak kasus, kebiasaan atau pola hidup yang diwariskan turun-temurun dapat memengaruhi kebiasaan makan, pola tidur, dan pilihan pengobatan yang mereka lakukan. Di beberapa komunitas, adat dan tradisi seperti konsumsi makanan tertentu atau pengobatan tradisional sangat dihargai. Jika program promosi kesehatan tidak memperhitungkan budaya setempat, maka program tersebut dapat dianggap asing atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Penting bagi promosi kesehatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang ada agar dapat diterima dan diterapkan secara luas oleh masyarakat (Kickbusch & Gleicher, 2020).

Pengaplikasian pendekatan budaya dalam promosi kesehatan telah dilakukan di berbagai negara dengan pendekatan yang beragam. Salah satu pendekatan budaya yang diterapkan adalah melalui penggunaan bahasa dan simbol yang dikenal oleh masyarakat setempat. Misalnya, di Indonesia, promosi kesehatan yang menggunakan bahasa lokal dan melibatkan tokoh adat atau pemimpin komunitas dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan tradisi lokal seperti upacara adat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat atau pentingnya vaksinasi juga telah terbukti efektif. Pendekatan lain yang banyak digunakan adalah kolaborasi dengan

penyuluh kesehatan yang memiliki pemahaman budaya lokal, seperti dukun kesehatan atau masyarakat adat yang dipercaya oleh komunitas tertentu. Dalam beberapa kasus, integrasi antara pengobatan tradisional dan medis modern juga menjadi pendekatan yang efektif, dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik (Pearson & Chatterjee, 2022).

B. Pengaruh Budaya Terhadap Kesehatan

Definisi Budaya

Budaya merujuk pada pola-pola kehidupan yang diturunkan melalui proses belajar sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya mencakup nilai, norma, tradisi, kebiasaan, bahasa, simbol, dan cara-cara hidup yang dikembangkan dan diterima oleh kelompok sosial tersebut. Budaya memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam masyarakat serta memberikan kerangka bagi individu untuk memahami dunia di sekitarnya. Dalam konteks kesehatan, budaya berperan dalam menentukan bagaimana masyarakat memandang dan merespons masalah kesehatan, serta memengaruhi pilihan-pilihan yang mereka buat terkait pola hidup, pengobatan, dan cara-cara untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental.

Berikut merupakan unsur-unsur budaya yang mempengaruhi kesehatan antara lain:

1. Nilai dan Kepercayaan

Nilai dan kepercayaan budaya suatu masyarakat menentukan bagaimana individu melihat kesehatan dan penyakit. Sebagai contoh, di beberapa budaya, kesehatan sering kali dipandang sebagai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional atau spiritual juga sangat mempengaruhi pilihan pengobatan yang diterima oleh masyarakat. Kepercayaan yang kuat terhadap penyebab penyakit (misalnya, pengaruh roh atau karma) dapat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan layanan kesehatan modern atau tradisional (Kickbusch & Gleicher, 2020).

2. Norma Sosial

Norma sosial adalah aturan atau standar yang diikuti oleh anggota masyarakat. Dalam konteks kesehatan, norma ini dapat mencakup sikap terhadap makanan, kebersihan, atau pola hidup sehat. Misalnya, di banyak masyarakat, norma sosial yang mengatur pola makan, seperti pembatasan konsumsi makanan tertentu, memiliki pengaruh besar pada kebiasaan makan individu dan masyarakat (Nutbeam, 2019).

3. Bahasa dan Komunikasi

Bahasa memainkan peran penting dalam penyampaian informasi kesehatan. Dalam beberapa kasus, hambatan bahasa atau perbedaan bahasa dapat mempengaruhi pemahaman dan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan. Selain itu, simbol atau metafora dalam budaya juga dapat mempengaruhi cara informasi kesehatan diterima dan dipahami. Misalnya, penggunaan simbol atau cerita rakyat dalam promosi kesehatan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat (Tannahill, 2021).

4. Praktik Tradisional

Setiap budaya memiliki praktik tradisional terkait kesehatan, seperti pengobatan herbal, pijat, atau penggunaan ritual tertentu untuk penyembuhan. Banyak komunitas masih sangat bergantung pada pengobatan tradisional atau metode alami dalam perawatan kesehatan mereka, meskipun layanan medis modern juga tersedia. Penghormatan terhadap praktik ini dapat memperkuat hasil promosi kesehatan jika dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya tersebut (Pearson & Chatterjee, 2022).

5. Struktur Sosial dan Keluarga

Struktur sosial dan peran dalam keluarga juga memengaruhi kesehatan. Dalam banyak budaya, keluarga adalah unit sosial yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Sebagai contoh, keputusan untuk mencari perawatan medis atau menjalani pengobatan tertentu sering kali melibatkan konsensus keluarga, dan ini dapat memengaruhi adopsi atau penolakan terhadap suatu pengobatan (WHO, 2021).

C. Contoh Pengaruh Budaya Terhadap Kesehatan

1. Pola Makan dan Kebiasaan Hidup Sehat

Pola makan dan kebiasaan hidup sehat sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Astina et al. (2023) menjelaskan bahwa pola makan yang seimbang, yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral, sangat diperlukan untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal. Selain itu, kebiasaan hidup sehat, seperti rutin berolahraga, cukup tidur, mengelola stres, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan, juga berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

Astina et al. (2023) menekankan pentingnya penerapan pola makan yang berbasis pada prinsip gizi seimbang, yang mencakup konsumsi berbagai jenis makanan dalam jumlah yang tepat. Misalnya, konsumsi sayur dan buah yang cukup, pemilihan sumber protein sehat seperti ikan atau kacang-kacangan, serta

pembatasan asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Hal ini berfungsi untuk mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

Kebiasaan hidup sehat lainnya, seperti aktivitas fisik yang teratur, juga memiliki dampak positif pada kesehatan jangka panjang. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi risiko obesitas dan penyakit terkait gaya hidup lainnya. Oleh karena itu, gaya hidup sehat yang mencakup pola makan yang tepat dan kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan tubuh adalah hal yang sangat penting dalam promosi kesehatan masyarakat.

2. Tradisi dan pantangan makanan dalam konteks kesehatan

Tradisi dan pantangan makanan dalam berbagai budaya sering kali berperan penting dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Dalam banyak budaya, pantangan makanan atau aturan makan tertentu tidak hanya dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial atau spiritual, tetapi juga dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah penyakit. Fitri dan Riyadi (2024) menjelaskan bahwa tradisi makanan yang ada dalam suatu masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, kepercayaan lokal, dan pengalaman turun-temurun yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental.

Pantangan makanan, seperti larangan mengonsumsi makanan tertentu selama periode tertentu atau dalam kondisi kesehatan tertentu, biasanya memiliki alasan yang berkaitan dengan keyakinan budaya atau kesehatan. Misalnya, dalam banyak budaya Asia, ada pantangan untuk mengonsumsi makanan yang dianggap "panas" atau "dingin" dalam konteks pengobatan tradisional untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam tradisi tertentu, ada pula aturan makan yang disesuaikan dengan usia atau kondisi fisik seseorang, seperti wanita hamil atau lansia yang memiliki pantangan tertentu terkait makanan untuk mendukung kesehatan mereka (Fitri & Riyadi, 2024).

Selain itu, beberapa tradisi makanan juga berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit atau pemeliharaan kesehatan secara umum. Contoh yang sering ditemukan adalah kebiasaan mengonsumsi rempah-rempah tertentu atau makanan fermentasi, yang dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau memperbaiki pencernaan. Di sisi lain, ada pula pantangan makanan yang bertujuan untuk menghindari risiko penyakit tertentu, seperti pantangan terhadap makanan yang terlalu berlemak untuk mencegah penyakit jantung atau hipertensi. Dalam konteks kesehatan, pemahaman terhadap tradisi dan pantangan makanan sangat penting, karena pendekatan ini dapat diintegrasikan

ke dalam program promosi kesehatan yang lebih sensitif terhadap budaya masyarakat. Jika kebiasaan makan dan pantangan ini dipahami dengan baik, maka intervensi kesehatan dapat lebih diterima dan diikuti oleh masyarakat.

D. Pendekatan Budaya dalam Promosi Kesehatan

1. Teori dan Model Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan sangat penting karena dapat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan intervensi kesehatan di masyarakat. Beberapa teori dan model pendekatan budaya digunakan untuk memastikan bahwa program kesehatan yang dirancang sesuai dengan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang ada dalam komunitas tertentu. Berikut adalah beberapa teori dan model yang digunakan dalam pendekatan budaya dalam promosi kesehatan:

a. Teori Keterlibatan Budaya

Teori ini berfokus pada pentingnya mengintegrasikan nilai dan norma budaya dalam setiap intervensi kesehatan. Keterlibatan budaya dalam program kesehatan memastikan bahwa pesan kesehatan disampaikan dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh komunitas yang bersangkutan. Hal ini dapat mencakup penggunaan bahasa lokal, simbol yang relevan, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau pemimpin budaya setempat (Tannahill, 2021).

b. Model Penerimaan Kultural (*Cultural Adaption Model*)

Model ini menekankan pentingnya adaptasi budaya dalam merancang intervensi kesehatan. Pendekatan ini mengakui bahwa intervensi kesehatan yang tidak disesuaikan dengan budaya masyarakat mungkin akan ditolak atau tidak efektif. Model ini mencakup langkah-langkah seperti memahami konteks sosial dan budaya, melibatkan masyarakat dalam desain program, dan memodifikasi metode atau strategi untuk mencocokkan dengan norma dan praktik setempat (Kickbusch & Gleicher, 2020).

c. Teori Ekologi Sosial

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kesehatan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor budaya yang lebih luas, seperti struktur sosial dan lingkungan. Menurut teori ini, intervensi kesehatan harus memperhitungkan konteks sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan, seperti peran keluarga, komunitas, dan institusi sosial lainnya. Model ini juga menekankan pentingnya mendekati masalah kesehatan dari berbagai tingkat, mulai dari individu hingga komunitas dan kebijakan publik (Nutbeam, 2019).

d. Model Transkultural dalam Keperawatan

Model ini dikembangkan oleh Madeleine Leininger dan berfokus pada pentingnya memahami perbedaan budaya dalam konteks perawatan kesehatan. Model ini mengajarkan bahwa perawatan kesehatan harus disesuaikan dengan budaya individu untuk meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan. Prinsip ini sering diterapkan dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa dihargai dan dipahami, terlepas dari latar belakang budaya mereka (Pearson & Chatterjee, 2022).

e. Model Penyuluhan Kesehatan yang Sensitif Budaya

Model ini mengutamakan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya dalam penyuluhan kesehatan. Intervensi kesehatan yang berhasil harus memperhitungkan perbedaan budaya dalam cara informasi disampaikan, serta cara masyarakat memandang dan mempraktikkan kesehatan. Penyuluhan yang efektif sering kali melibatkan penggunaan metode komunikasi yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai budaya lokal, misalnya menggunakan cerita rakyat, seni tradisional, atau melibatkan pemimpin adat dalam kampanye kesehatan (WHO, 2021).

2. Implementasi Promosi Kesehatan Berbasis Budaya

Implementasi promosi kesehatan berbasis budaya mengacu pada upaya untuk mengadaptasi pesan-pesan kesehatan agar lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya tertentu. Pendekatan ini penting karena budaya dapat mempengaruhi pemahaman, persepsi, dan perilaku seseorang terhadap kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi promosi kesehatan berbasis budaya:

a. Program Edukasi Gizi di Kalangan Masyarakat Adat

Salah satu contoh implementasi promosi kesehatan berbasis budaya adalah program edukasi gizi yang disesuaikan dengan kebiasaan makan dan pola hidup masyarakat adat. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat adat memiliki pola makan tradisional yang kaya akan bahan-bahan alami, namun kurang memperhatikan keseimbangan gizi. Dalam program ini, pendidik kesehatan bekerja sama dengan tokoh adat dan menggunakan bahasa serta simbol budaya setempat untuk menyampaikan pentingnya konsumsi gizi yang seimbang, sambil tetap mempertahankan keanekaragaman kuliner lokal. Ini mencakup upaya untuk mengedukasi tentang pentingnya sayur dan buah dalam diet sehari-hari tanpa menghilangkan keunikan masakan tradisional mereka (Fitri & Riyadi, 2024).

b. Kampanye Kesehatan Berbasis Agama di Masyarakat Muslim

Program promosi kesehatan berbasis budaya juga dapat melibatkan nilai-nilai agama. Sebagai contoh, di banyak komunitas Muslim, promosi kesehatan tentang gaya hidup sehat dapat dikaitkan dengan ajaran agama, seperti pentingnya menjaga kebersihan, puasa sebagai cara untuk detoksifikasi tubuh, dan pentingnya memberi makan orang miskin (zakat). Kampanye ini menggunakan konsep-konsep yang sudah diterima oleh masyarakat, seperti menjelaskan pentingnya puasa untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta menjaga keseimbangan tubuh. Pemanfaatan tokoh agama untuk menyampaikan pesan kesehatan ini juga dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan (Tannahill, 2021).

c. Penggunaan Cerita Rakyat untuk Edukasi Kesehatan

Di beberapa budaya, cerita rakyat atau legenda tradisional memiliki kekuatan yang besar dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai kehidupan. Dalam promosi kesehatan berbasis budaya, cerita rakyat digunakan untuk menyampaikan informasi penting mengenai pencegahan penyakit, pentingnya kebersihan, atau cara mengelola stres. Misalnya, dalam beberapa komunitas di Asia Tenggara, cerita-cerita tentang pahlawan yang kuat dan sehat dapat diadaptasi untuk mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Pendekatan ini memanfaatkan media yang sudah dikenal oleh masyarakat untuk membuat pesan kesehatan lebih mudah dipahami dan diterima (Pearson & Chatterjee, 2022).

d. Program Vaksinasi dengan Pendekatan Budaya

Program vaksinasi di beberapa daerah dengan latar belakang budaya tertentu sering kali menghadapi tantangan terkait penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Dalam hal ini, pendekatan budaya sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Sebagai contoh, di beberapa komunitas yang lebih tradisional, program vaksinasi disampaikan melalui penggunaan pemimpin lokal atau tokoh adat yang memiliki pengaruh besar, untuk menjelaskan manfaat vaksin secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, dalam beberapa kasus, vaksinasi diintegrasikan dengan ritual atau acara budaya yang melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga menjadi bagian dari kegiatan sosial yang mendukung kesehatan (WHO, 2021).

E. Studi Kasus

1. Penerapan Pendekatan Budaya dalam Masyarakat

Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan sangat penting dalam memastikan keberhasilan program kesehatan, terutama di komunitas dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di bawah ini adalah beberapa studi kasus yang menunjukkan penerapan pendekatan budaya dalam masyarakat.

Penerapan Promosi Kesehatan di Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan

Salah satu contoh penerapan pendekatan budaya dalam promosi kesehatan dapat ditemukan di komunitas adat Dayak di Kalimantan, Indonesia. Dalam hal ini, promosi kesehatan tentang pencegahan penyakit menular dan pola hidup sehat diterapkan dengan cara yang sangat sensitif terhadap budaya mereka. Program ini melibatkan pemimpin adat untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, menggunakan cerita dan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal oleh masyarakat Dayak.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada pengedukasian masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi dan sanitasi yang baik, tetapi juga memanfaatkan praktik tradisional dalam menjaga kesehatan. Misalnya, penggunaan tanaman obat lokal yang sudah lama dipercaya oleh masyarakat Dayak. Hal ini meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan, karena mereka merasa bahwa intervensi tersebut tidak mengabaikan budaya mereka, tetapi justru mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang sudah ada. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan lingkungan (Yuliana et al., 2022).

2. Hasil dan Dampak dari Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan terbukti memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan kesehatan. Penerapan intervensi kesehatan yang disesuaikan dengan nilai dan norma budaya lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat partisipasi komunitas dalam menjaga kesehatan mereka. Berikut adalah beberapa studi kasus yang menunjukkan hasil dan dampak dari penerapan pendekatan budaya dalam promosi kesehatan.

Sebuah studi yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa program promosi kesehatan reproduksi yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat dapat mengurangi angka kehamilan remaja dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Program ini melibatkan

pemimpin agama dan tokoh budaya lokal untuk menyampaikan informasi kepada remaja, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kepercayaan mereka dan mempertimbangkan norma budaya yang ada.

Pendekatan budaya ini melibatkan penyuluhan melalui acara-acara budaya, seperti pertunjukan seni dan kegiatan masyarakat yang relevan dengan budaya lokal, yang berfungsi untuk mengedukasi tanpa mengganggu nilai-nilai adat yang berlaku. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi serta penurunan angka kehamilan di kalangan remaja (Nugroho et al., 2023). Dampak positif lainnya adalah peningkatan komunikasi antara orang tua dan anak mengenai isu-isu sensitif seperti kesehatan seksual.

F. Rekomendasi

1. Strategi meningkatkan efektivitas pendekatan budaya

Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan adalah kunci untuk memastikan keberhasilan intervensi di berbagai komunitas, terutama yang memiliki tradisi dan nilai-nilai budaya yang kuat. Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini, beberapa strategi perlu dipertimbangkan agar intervensi kesehatan dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan budaya dalam promosi kesehatan:

a. Melibatkan Tokoh Budaya dan Pemimpin Komunitas

Mengintegrasikan pemimpin lokal dan tokoh budaya dalam setiap program promosi kesehatan adalah salah satu strategi yang dapat meningkatkan efektivitas. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan dengan cara yang lebih diterima oleh komunitas mereka. Melalui kolaborasi ini, program-program kesehatan dapat disesuaikan dengan nilai dan norma lokal, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dan keberhasilan intervensi (Hernandez et al., 2022).

b. Penyuluhan yang Sensitif terhadap Stigma Sosial dan Kesehatan Mental

Program promosi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti kesehatan mental atau penyakit menular, perlu dikembangkan dengan pendekatan yang sensitif terhadap stigma sosial yang mungkin ada. Penyuluhan harus dilakukan dengan cara yang menghargai norma-norma budaya sambil mengedukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan yang dianggap tabu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai

budaya dan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi, program ini dapat lebih diterima dan efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang sensitif (Al-Khateeb et al., 2023).

2. Penelitian lebih lanjut dampak pendekatan budaya

Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan kesehatan. Namun, untuk mengoptimalkan hasil dan memastikan keberlanjutan program, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi dampak jangka panjang, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas dari penerapan pendekatan budaya dalam konteks yang berbeda. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang dampak pendekatan budaya dalam promosi kesehatan.

a. Penelitian tentang Dampak Jangka Panjang Pendekatan Budaya terhadap Perubahan Perilaku Kesehatan

Sebagian besar penelitian yang ada saat ini masih fokus pada dampak jangka pendek dari intervensi berbasis budaya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang dampak jangka panjang, terutama terkait dengan perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Penelitian ini dapat melibatkan analisis longitudinal untuk memantau perubahan dalam pola makan, kebiasaan berolahraga, atau kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang lebih panjang setelah program promosi kesehatan berbasis budaya dilaksanakan (Singh et al., 2021).

b. Pengaruh Pendekatan Budaya terhadap Kesehatan Mental dan Kesejahteraan

Banyak penelitian saat ini lebih fokus pada aspek fisik dari promosi kesehatan berbasis budaya. Namun, ada sedikit penelitian yang mengeksplorasi bagaimana pendekatan budaya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu, terutama dalam konteks komunitas yang mengalami stigma sosial atau marginalisasi. Penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara pendekatan budaya dan peningkatan kesehatan mental atau pengurangan stigma terkait kesehatan mental akan sangat bermanfaat untuk merancang intervensi kesehatan yang lebih holistik (Martinez et al., 2021).

G. Simpulan

Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan. Dengan mengintegrasikan nilai, tradisi, dan praktik budaya setempat, pendekatan ini mampu mengurangi hambatan budaya yang sering kali muncul dalam penerimaan pesan kesehatan dari luar. Hal ini tidak hanya meningkatkan

efektivitas program, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan di kalangan masyarakat. Pentingnya promosi kesehatan berbasis budaya terletak pada kemampuan untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berbeda. Beberapa elemen kunci yang mendukung keberhasilan pendekatan ini termasuk keterlibatan tokoh budaya dan pemimpin komunitas, penggunaan media tradisional dan digital, serta adaptasi pesan kesehatan yang sensitif terhadap stigma dan kepercayaan lokal.

Namun, meskipun banyak penelitian menunjukkan dampak positif, masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terkait dampak jangka panjang, efektivitasnya di berbagai kelompok budaya, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendekatan ini. Penelitian lebih lanjut akan membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dan fleksibel dalam mengimplementasikan promosi kesehatan berbasis budaya di berbagai komunitas. Secara keseluruhan, pendekatan budaya dalam promosi kesehatan merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kesehatan mental, fisik, dan sosial, serta membangun keberlanjutan dalam upaya peningkatan kesehatan di tingkat komunitas.

H. Referensi

- Al-Khateeb, A., Nazzal, Z., & Abu-Rmeileh, N. (2023). Cultural-based health promotion: Addressing nutrition and health behaviors in the Middle East. *Journal of Health Promotion and Education*, 31(1), 22-30. <https://doi.org/10.1080/17538068.2022.2022056>
- Astina, I., Susanti, N. S., & Wulandari, D. (2023). Pola makan dan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit degeneratif. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(1), 47-55. <https://doi.org/10.12345/jkm.v19i1.567>
- Fitri, L., & Riyadi, S. (2024). Tradisi dan pantangan makanan dalam konteks kesehatan: Pengaruh budaya terhadap pola makan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(2), 112-120. <https://doi.org/10.12345/jkm.v20i2.789>
- Hernandez, M., Castro, F., & López, G. (2022). Cultural adaptation of mental health promotion programs in Latinx communities in the U.S. *American Journal of Community Psychology*, 69(3), 289-299. <https://doi.org/10.1002/ajcp.1245>
- Martinez, A., Garcia, M., & Ramos, R. (2021). Cultural interventions in smoking cessation programs for traditional communities in the Philippines. *International Journal of Public Health*, 66(6), 1009-1017. <https://doi.org/10.1007/s00038-021-01506-1>

- Nugroho, A., Wulandari, T., & Sari, D. (2023). The impact of culturally tailored reproductive health education in reducing teenage pregnancy in Indonesia. *Journal of Adolescent Health, 72*(4), 435-442. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.12.007>
- Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-promotion>
- Singh, A., Gupta, R., & Sharma, N. (2021). Cultural adaptation in health interventions: A case study of vaccination programs in rural India. *International Journal of Public Health, 66*(6), 795-802. <https://doi.org/10.1007/s00038-021-01512-3>
- Tannahill, A. (2021). What is health promotion? *Health Promotion Journal of Australia, 32*(1), 6-8. <https://doi.org/10.1002/hpja.436>
- Yuliana, M., Fitri, L., & Setiawati, D. (2022). Penerapan promosi kesehatan berbasis budaya di masyarakat adat Dayak: Studi kasus di Kalimantan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 18*(2), 108-115. <https://doi.org/10.12345/jkmi.v18i2.356>

CHAPTER 5

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PROMOSI KESEHATAN

Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesenjangan kesehatan yang sangat besar dalam kesehatan masyarakat, khususnya antar negara maju dan negara berkembang di dalam satu negara tidak dapat diterima secara politik, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu menjadi perhatian bersama pada semua negara. Pembangunan ekonomi dan sosial, berdasarkan tatanan ekonomi sangat penting dalam mencapai kesehatan secara menyeluruh pada setiap orang dan mengurangi kesenjangan status kesehatan antara negara maju dan negara berkembang terhadap akses layanan kesehatan, tinginya angka kematian ibu dan anak, penyakit menular serta malnutrisi. Maka diadakan Konferensi Internasional Alma-Ata yang diselenggarakan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *United National Internasional Children's Emergency Fund* (UNICEF) secara resmi pada tanggal 12 September 1978 tentang *Primary Health Care* berfokus pada pencegahan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pencapaian "*Health for All*" pada Tahun 2000 dan merupakan cikal bakal Promosi Kesehatan (WHO, 1978).

Konferensi Internasional promosi kesehatan pertama kali diselenggarakan di Ottawa pada tanggal 21 November 1986 menghasilkan Piagam Ottawa yang merupakan landasan utama dalam pengembangkn kebijakan kesehatan. Strategi promosi kesehatan menekankan pada lima pilar kegiatan yaitu membentuk kebijakan publik yang mendukung kesehatan, menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat aksi/gerakan masyarakat, mengembangkan keterampilan individu, tindakan komunitas seperti memberdayakan dan reorientasi pelayan kesehatan (WHO, 1986).

Promosi kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari Sejarah Kesehatan Masyarakat yaitu dimulainya program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) pada tahun 1975 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa berbasis komunitas sebagai strategi pelayanan kesehatan primer sejalan dengan Deklarasi Alma Ata Tahun 1978 dan Piagam Ottawa 1986. Program PKMD yaitu berupa program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan melakukan pemberdayaan kader kesehatan dari masyarakat lokal dalam memberikan edukasi

kesehatan dan pemantauan kesehatan masyarakat. Kemudian Konferensi Internasional diselenggarakan oleh WHO tanggal 25 Juli 1997 yaitu Deklarasi Jakarta tentang Promosi Kesehatan IV dan tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

B. Pemberdayaan Masyarakat/ Community Empowerment

Pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua kata pemberdayaan "*empowerment*" dan masyarakat "*communities*". *Empower* yaitu memberikan otoritas, mendelegasikan kewenangan, kekuasaan, dan izin dengan kata lain Pemberdayaan/ *empowerment* yaitu memberikan kewenangan atau kesempatan sumber daya kepada individu ataupun kelompok dalam meningkatkan kapasitas sumber daya dalam mengambil keputusan atau mengelola kehidupan secara pribadi. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mungkin yang tinggal di wilayah yang sama, memiliki minat, perhatian atau identitas yang sama dan memiliki hubungan sosial satu sama lain.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu untuk membuat seseorang lebih kuat dan lebih percaya diri terutama dalam mengendalikan hidup mereka dan menuntut hak-hak (Pearsaal, 1998). konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah pembangunan yang digerakan masyarakat (*Empowerment Group*). Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dalam membangun kesadaran, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengenali, mengatasi, merawat, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri (Notoatmodjo, 2007). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses negosiasi ulang yang melibatkan partisipasi aktif dengan melibatkan masyarakat untuk mendorong perubahan. Proses ini melibatkan negosiasi ulang dengan melibatkan orang yang yang dapat diberdayakan serta berbagi kekuasaan guna memperoleh kontrol yang lebih besar (Baum, 2008).

Konsep pemberdayaan dalam perawatan kesehatan adalah dicirikan oleh partisipasi aktif, perubahan yang terinformasi (perubahan seseorang setelah memperoleh pengetahuan yang relevan, misal tentang pola makan sehatm aktivitas fisik, serta pengetahuan, tanggungjawab perawatan diri, rasa kendali, kesadaran, pengembangan keterampilan diri, otonomi dan kemampuan mengatasi masalah. (Fotoukian, Z., et all, 2014). Menurut Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan ide dasar dalam promosi kesehatan yang dapat membantu masyarakat dalam menentukan prioritas, membuat pilihan, mengembangkan strategi dan melaksanakannya untuk meningkatkan kesehatan dan meminimalkan ketidaksetaraan dalam kesehatan. Pemberdayaan masyarakat menjadi acuan paradigma bagi teori dan praktik dalam promosi kesehatan (Kruahong et al, 2023). Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu serta kelompok dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Konteks pemberdayaan membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, serta merancang dan menerapkan solusi yang sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mandiri.

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Haugan, G., Eriksson, M. (2021), Prinsip-prinsip panduan dasar dalam promosi kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan yaitu memungkinkan individu dan komunitas untuk memiliki lebih banyak kendali atas faktor-faktor pribadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan.
2. Partisipatif yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam setiap proses.
3. Holistik yaitu meningkatkan kesehatan fisik, mental, sosial dan spritual.
4. Keadilan dan keadilan sosial yaitu setiap individu dan komunitas mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya kesehatan dan layanan kesehatan.
5. Berkelanjutan dan berkesinambungan yaitu menciptakan perubahan mulai dari awal sampai jangka panjang.
6. Multistrategi yaitu menggunakan beberapa pendekatan dan metode dalam melaksanakan promosi kesehatan, sehingga memberikan dampak yang lebih efektif.

Dasar-dasar filosofi pemberdayaan masyarakat dalam hubungannya dengan fasilitas dan tenaga kesehatan, partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk mencukupi kelangkaan tersebut. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dapat

menciptakan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diciptakan dengan adanya partisipasi masyarakat didasarkan kepada idealisme:

1. *Community felt need*

kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Suatu layanan kesehatan diciptakan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, ini berarti bahwa masyarakat itu memerlukan pelayanan tersebut. Sehingga adanya pelayanan kesehatan bukan karena diturunkan dari atas (top-down), yang belum dirasakan perlunya, tetapi tumbuh dari bawah (bottom-up) sehingga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan layanan kesehatan yang diperlukan masyarakat dan untuk masyarakat.

2. Organisasi pelayanan kesehatan masyarakat

Yang berdasarkan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Hal ini berarti bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu timbul dari masyarakat sendiri. Masyarakat memiliki peran utama dalam menentukan, merancang, mengembangkan layanan kesehatan.

3. Pelayanan kesehatan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat sendiri.

Artinya tenaganya dan penyelenggaraannya akan ditangani oleh anggota masyarakat itu sendiri yang dasarnya sukarela dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat suatu proses yang memungkinkan orang untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi hidup mereka. Tugas pemberdayaan masyarakat :

1. Mengendalikan hidup mereka sendiri: mampu membuat keputusan dan prioritas serta mengembangkan strategi terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan dan masalah kesehatan individu, kelompok dan masyarakat.
2. Mempraktikkan perubahan (perubahan positif): berpartisipasi aktif menjadi agen perubahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan.
3. Memobilisasi dan menggunakan sumber daya: masyarakat mampu mengakses sumber daya yang tersedia seperti informasi, fasilitas kesehatan, dukungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan
4. Mendapatkan layanan yang menangani perawatan kesehatan dalam masyarakat : setiap masyarakat mendapatkan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas mulai dari ketersediaan layanan di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil serta bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat.

5. Menanggulangi risiko dan perilaku kesehatan : memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat untuk mampu mencegah terjadinya suatu masalah kesehatan seperti melakukan pola hidup sehat, gerakan masyarakat sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat (Sumarjo (1999); Skar, R., Wahlen, S., & Bondas, T.E. (2021)).

Ciri Pemberdayaan Masyarakat

Adapun ciri pemberdayaan masyarakat terdiri dari 7 unsur yaitu sebagai berikut :



Gambar 5.1 Ciri Pemberdayaan Masyarakat

1. Tokoh atau pemimpin masyarakat (*community leaders*)

Merupakan individu yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam suatu komunitas dalam membimbing, mengorganisi dan memfasilitasi kegiatan sosial, ekonomi, budaya , politik untuk kepentingan masyarakat, Kegiatan ini bisa dilakukan dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin yang mempunyai kewenangan di wilayah tersebut seperti camat, lurah, ketua RW/ RT. Pendekatan informal yang dipercayai dan mampu mempengaruhi individu, kelompok atau masyarakat seperti tokoh agama, kepala adat.

2. Organisasi masyarakat (*community organization*)

Merupakan kelompok atau wadah yang dibentuk oleh sekelompok individu dalam suatu komunitas dengan tujuan untuk bekerjasama dalam negosiasi

permasalahan sosial, meningkatkan kesejahteraan serta memperjuangkan kepentingan bersama. Kelompok tani, koperasi, komunitas ibu-ibu PKK, kelompok karang taruna, organisasi pemuda.

3. Pendanaan masyarakat (*community fund*)

Merupakan mekanisme penggalangan dan pengelolaan dana yang berasal dari individu, kelompok, atau organisasi dalam suatu komunitas untuk membiayai kegiatan sosial, pembangunan, atau program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembentukan dana sehat, dana kegiatan posyandu balita, dana posyandu lansia, tabungan ibu bersalin, dana kematian.

4. Material masyarakat (*Community material*)

Merupakan segala bentuk sumber daya fisik dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu komunitas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kegiatan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan. Material ini mencakup air bersih, sarana kegiatan posyandu.

5. Pengetahuan masyarakat (*community knowledge*)

Merupakan pemahaman, informasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu komunitas yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan interaksi sosial. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, budaya, teknologi, serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk promosi kesehatan, pengetahuan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan. Kegiatan ini mencakup penyuluhan kesehatan.

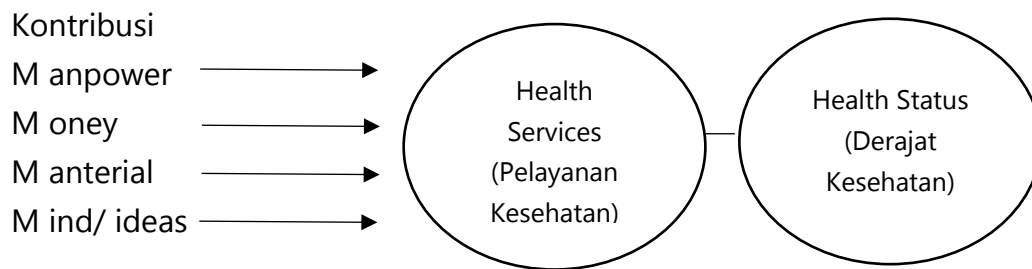
6. Teknologi masyarakat (*community technology*)

Merupakan berbagai bentuk teknologi yang dikembangkan, dimanfaatkan, dan diterapkan oleh suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Teknologi ini bisa berupa inovasi sederhana maupun canggih yang berbasis pada sumber daya lokal, kearifan tradisional, atau hasil adaptasi dari teknologi modern. Saringan air dari pasir dan batu, pengawetab makanan dengan pengasapan, pemandaatan tanaman tonaman obat keluarga, pemanfaatan alat kesehatan sederhana.

7. Pembuatan keputusan oleh masyarakat (*Community Decision Making*):

Merupakan proses di mana masyarakat secara kolektif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, penentuan prioritas, perencanaan solusi, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil keputusan.

Setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan) (Yusriani, Alwi., M. K. (2018). Supaya Lebih jelas dapat di gambarkan sebagai berikut :

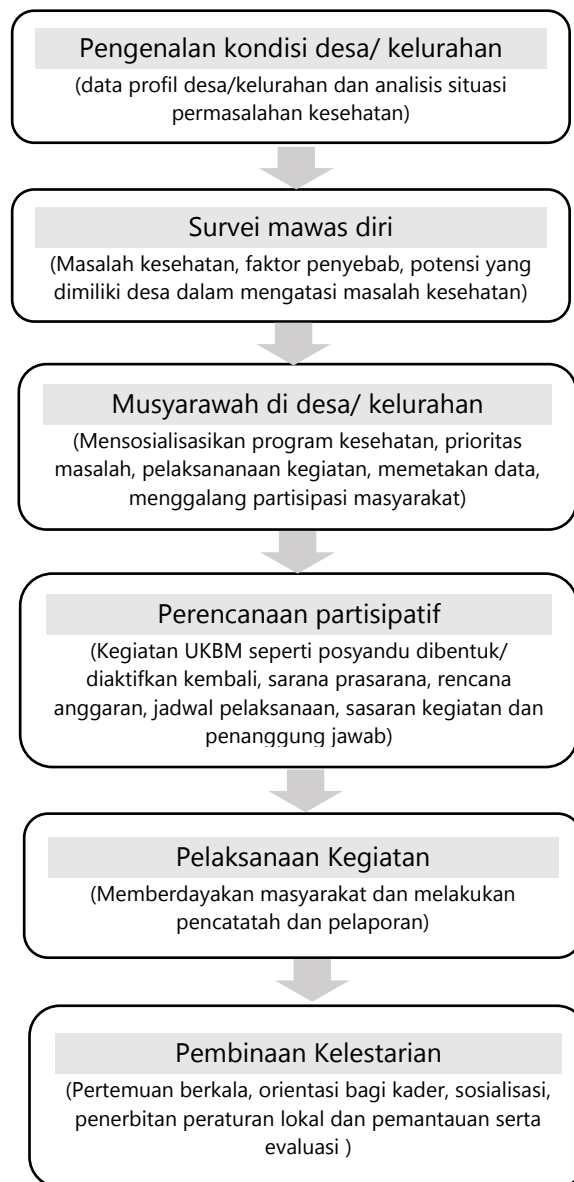


Gambar 5.2 4M

Pembuatan keputusan oleh masyarakat Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengelola sumber daya dalam meningkatkan status kesehatan. Maka diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat. Berikut Strategi pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 :

1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat.
3. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
4. Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan.
5. Peningkatan kemitraan an partisipasi lintas sektotr, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan swasta.
6. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal.
7. Pengintegrasian program, kegiatan, dan/ atau kelembagaan pemberdayaan masysarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.
8. Mengendalikan hidup mereka sendiri : mampu membuat keputusan dan prioritas serta mengembangkan strategi terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan dan masalah kesehatan individu, kelompok dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat meliputi 6 tahap :



Gambar 5.3 Penyelenggaraan Pembardayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan berkontribusi pada efektivitas inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat dimana anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil kesehatan. Peran kampanye pendidikan dan kesadaran dalam membekali individu dengan penegetahuan yang diperlukan untuk membuat pilihan gaya hidup yang tepat. Dengan memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka, untuk menciptakan perubahan yang langgeng yang tidak hanya mempromosikan kesejahteraan individu tetapi juga ketahanan kolektif terhadap tantangan kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat yang berkelanjutan,. Bagian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan individu dan

kolektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam lokakarya, forum, dan diskusi kelompok, mereka dapat menyampaikan kebutuhan mereka, berbagi wawasan, dan bekerja sama dalam mencari solusi. Ini tidak hanya memperkuat tanggung jawab bersama tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

C. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM):

1. Integrasi Layanan Primer (ILP) pendekatan ILP di puskesmas pembantu dimana ada 2 kader yang diberdayakan dalam sistem kesehatan yang menggabungkan berbagai layanan kesehatan dasar secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berperan dalam meningkatkan layanan kesehatan dasar dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri.
3. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
Kegiatan ini yaitu dilaksanakan 1 bulan sekali di lingkungan masyarakat baik didesa/ kelurahan, kantor, sekola dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai kader dalam melakukan pelayanan fungsi 5 meja. Kegiatan ini bisa diikuti oleh remaja, dewasa maupun lansia.
4. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat desa. Poskesdes bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dengan prinsip pelayanan berbasis masyarakat.
5. Upaya Kesehatan Kerja (UKK) salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) melibdungi, meningkatkan, dan memelihara kesehatan pekerja di wilayah desa/ kelurahan yang melibatkan peran aktif pekerja dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.
6. Dana desa
Dana desa yaitu merupakan iuran warga, ataupun bantuan yang dialokasikan untuk masyarakat untuk kesehatan yang terorganisir kepesertaan dan pendanaan.

7. Tanaman obat keluarga (toga)

Melibatkan kader kesehatan dan pokja desa dalam mengedukasi kepada masyarakat mengenai tanaman obat keluarga yang bisa ditanam di pekarangan rumah.

Indikator hasil pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Input

Input meliputi SDM (pemerintah/ lembaga/ institusi, pemimpin, tokoh masyarakat, toko agama, lembaga swadaya masyarakat dan kader), dana, bahan-bahan, alat-alat serta adanya metode yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Proses

Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan seperti jenis dan jumlah KIE/ penyuluhan yang dilaksanakan, frekuensi pelatihan yang dilaksanakan, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat, Dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan.

3. Output

Output, meliputi jumlah dan jenis usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat, jumlah masyarakat yang telah meningkatkan pengetahuan dari perilakunya tentang kesehatan, jumlah anggota keluarga yang memiliki usaha yang meningkatkan pendapatan keluarga, dan meningkatkan fasilitas umum dimasyarakat.

4. Outcome

Outcome dari pemberdayaan masyarakat mempunyai kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, Dan angka kelahiran serta meningkatkan status gizi kesehatan (Susilowati, 2016; Rosdiana, 2022).

D. Evidence Based –Community Empowerment

Hasil penelitian analisis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan penelitian pada 10 Puskesmas mengenai gambaran aspek pemberdayaan masyarakat berdasarkan 7 variabel 1) keaktifan tokoh masyarakat (100%), 2) ketersediaan organisasi kemasyarakatan dan UKBM (100%), 3) ketersediaan dana masyarakat (70%), 4) pemanfaatan sarana masyarakat (100%), 5) penggunaan pengetahuan masyarakat (80%), 6) teknologi dari masyarakat (80%) dan 7) pembuatan keputusan oleh masyarakat (60%) 3 aspek terlaksana secara optimal keaktifan tokoh masyarakat, ketersediaan organisasi kemasyarakatan dan UKBM dan pemanfaatan sarana masyarakat dan 4 aspek belum terlaksana secara optimal seperti 1) ketersediaan dana masyarakat , penggunaan pengetahuan masyarakat, teknologi dari masyarakat dan pembuatan keputusan oleh masyarakat. Jenis organisasi pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil observasi yang banyak

dilaksanakan yaitu posyandu yang berjalan pada Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat baik tingkat desa maupun tingkat RW (Restuastuti, T., Zahtamal, Chandra, F., Restila, R., 2017).

Hasil penelitian analisis pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa Jawa Barat dimana kondisi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara langsung (*direct*). Dimana masyarakat berpartisipasi secara langsung sesuai instruksi atau kebijakan dari kepala desa. Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat kepada potensi, sumberdaya kearifan lokal, dana, dan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal. Adanya dukungan dari petugas kesehatan, kepala desa, bantuan kader, dan tokoh-tokoh dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat memberikan kepedulian dan perlindungan terhadap program di masyarakat. Kesadaran masyarakat akan muncul melalui dukungan sosial dan penyuluhan. Kader akan menjadi fasilitator mendapatkan informasi dan keterampilan yang memadai, pemberian sarana informasi yang tepat diperlukan dalam pemberdayaan kader sehingga dapat meningkatkan pemberian informasi yang berkesinambungan dan mudah diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan (Waluyo, E.M.J., Kusumawaty, J., Novianti, E., Iismayanti, L., Nurapandi, A., 2023).

E. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat

Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat untuk promosi kesehatan mencakup kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan, partisipasi masyarakat yang rendah seperti kurangnya motivasi dan akibat ketergantungan pada pihak lain, serta faktor sosial dan budaya seperti tokoh masyarakat atau agama dalam mendukung pemberdayaan masyarakat untuk selalu mendukung perubahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kesehatan, fasilitas, dan dana menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta juga memperlambat efektivitas program. Resistensi terhadap perubahan serta ketakutan akan ketidakpastian hasil semakin pada proses pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif agar masyarakat lebih aktif dalam meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri.

F. Kesimpulan

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan derajat kesehatan mereka. Pemberdayaan ini melibatkan

berbagai pendekatan, seperti peningkatan pengetahuan, advokasi, pengorganisasian komunitas, serta pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, mereka dapat mengidentifikasi permasalahan kesehatan, menetapkan prioritas, serta mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, keberhasilan promosi kesehatan sangat bergantung pada dukungan sosial, kebijakan publik, dan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kesehatannya, menciptakan lingkungan yang sehat, serta memperkuat akses layanan kesehatan secara berkelanjutan.

G. Referensi

- Alma Ata Declaration. (1978). Declaration of Alma-Ata: International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 The. Alma Ata. https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf?ua=1
- Baum, F. (2008) Foreword to Health promotion in action: from local to global empowerment. <https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/seventh-global-conference/community-empowerment>
- Fotoukian, Z., Shahboulaghi, F.M., Khoshknab ,M.F., Mohammadi,E. Concept analysis of empowerment in old people with chronic diseases using a hybrid model. *Asian Nurs Res.* 2014;8:118–27.
- Haugan, G., Eriksson, M. (2021). An Introduction to the Health Promotion Perspective in the Health Care Services in Health Promotion in Health Care Vital Theories and Research. Springer; p : 3-14
- Kruahong, S., Tankumpuan, T., Kelly, K., Davidson, P.M., & Kuntajak, P. (2023). Community empowerment: A concept analysis. *Journal of Advanced Nursing* Volume 79, Issue 8 p. 2845-2859. <https://doi.org/10.1111/jan.15613>
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pearsall J, editor. *The new Oxford dictionary of English*. Oxford: Clarendon Press; 1998.
- Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2019 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Jakarta; 2019
- Restuastuti, T., Zahtamal, Chandra, F., Restila, R., 2017. Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.14-19>
- Rosdiana. (2022). *Dasar Promosi Kesehatan*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center.
- Sibanda, A. M., Tazanios, M., & Tzenios, N. (2023). Community Empowerment as a tool for health promotion. *Cambridge Open Engage*. doi:10.33774/coe-

2023-clplt.<https://www.cambridge.org/engage/coe/article-details/63bacc0974e09513901279b4>

Skar, R., Wahlen, S., & Bondas, T. (Eds.). (2021). *Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63135-2>

Susilowati, D. (2016). Promosi Kesehatan. Jakarta ; Kemenkes RI

Waluyo, E.M.J., Kusumawaty, J., Noviati, E., Ilsmayanti, L., Nurapandi, A. (2023). Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Desa Srinabaya Kecamatan Rajdesa Jawa Barat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Daarul Ilmu. Vol 01 No. 02 Juli-Desember 2023 Hal. 51-63. <https://ojs.stikesmucis.ac.id/index.php/daipkm/article/view/390/257>

World Health Organization. The Ottawa charter for health promotion. Geneva: WHO; 1986.

Yusriani, Alwi., M. K. (2018). Buku Ajar Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. (Suhagyo, ed). Ponorogo: Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES) http://www.researchgate.net/publication/326893019_20180527-yusrianipromkesdan_pemberdayaanmasy. Accessed December 6, 2018.

H. Glosarium

ILP = Intergasti Layanan Primer

PKMD = Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa

Posbindu = Pos Pembindan Terpadu

Posyandu = Pos Pelayanan Terpadu

Pustu = Puskesmas Pembantu

Toga = Tanaman Obat Keluarga

UKBM = Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

CHAPTER 6

PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERBASIS KOMUNITAS

Wittin Khairani, S.Pd., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Indonesia merupakan negara tropis dimana merupakan kawasan endemik sebagai penyebaran penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit yang penyebaran dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke orang atau permukaan atau makanan. Menurut pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (*centers for disease control and prevention*) di Indonesia ada beberapa jenis penyakit menular yang umum terjadi, yakni: Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), Infeksi saluran pernafasan dapat menyerang hidung, tenggorokan, saluran nafas dan paru-paru, demam tifoid, diare, tuberkulosis, demam denque, cacingan, penyakit kulit, dan malaria. Beragam penyakit menular tersebut merupakan masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penularan penyakit bila tidak segera dicegah dan diberantas. Tentu saja kondisi ini merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (Achmadi,UF, 2010)

Berdasarkan data melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes tahun 2024, mengungkapkan penyakit Tuberkulosis (TB) dengan angka kematian 33,24 per 100.000 penduduk dan penyakit paru kronis dengan angka kematian 28,89 per 100.000 penduduk. Selanjutnya penyakit diare di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama. Hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kesakitan dan kematian terutama pada balita. Diperkirakan lebih dari 1.3 miliar serangan dan 3,2 juta kematian pertahun pada balita disebabkan oleh diare. Prevalensi kasus demam tifoid di Indonesia tahun 2024 adalah 1,6 % dari populasi. Demam tifoid merupakan penyakit menular yang menempati urutan ke -5 di Indonesia. Prevalensi demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia pada tahun 2023 adalah 0,64 %. Angka ini didapatkan dari pemeriksaan sampel 877.531 orang. Rincian kasus DBD di Indonesia tahun 2023 adalah : Jumlah kasus DBD terdapat 114.435 kasus, jumlah kematian DBD : 894 kematian, kasus DBD tersebar di 474 kabupaten/kota di 35 propinsi dan kematian DBD tersebar di 226 kabupaten/kota di 33 provinsi. Jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 418.546 kasus malaria. Jumlah ini menjadikan malaria sebagai

penyakit menular tertinggi ke dua di Indonesia setelah tuberculosis (TBC). (P2P, Kemenkes, 2024)

Oleh sebab itu penting ada program pemberantasan penyakit menular meliputi upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit. Upaya pencegahan penyakit menular dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, melindungi secara spesifik, mengendalikan faktor risiko, memperbaiki gizi masyarakat. Upaya pengendalian penyakit menular dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit. Dan upaya pemberantasan penyakit menular dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan.

Program pemberantasan penyakit menular di lingkungan masyarakat tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan bila tidak melibatkan peran aktif masyarakat dan komunitas di lingkungan. Maka diperlukan program pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas. Masyarakat sangat perlu diberdayakan dalam program pemberantasan penyakit menular meliputi upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit.

Berdasarkan penelitian (Varkey, Kureshi, Lesnick, 2010), *Empowerment of women and its association with the health of the community* mengungkapkan bahwa pemberdayaan wanita terkait dengan beberapa indikator kesehatan di tingkat nasional. Temuan lain dari hasil penelitian (Shrestha, 2013), *A conceptual model for empowerment of the female community health volunteers in Nepal*, mengungkapkan bahwa pemberdayaan relawan kesehatan rakyat, dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah fertilitas yang tinggi dan penyebabnya serta meningkatkan kemampuan dan kepercayaan terhadap penyediaan layanan kontrasepsi akan membawa perubahan yang berkesinambungan dalam hasil pekerjaan yang terkait dengan promosi penggunaan kontrasepsi di dalam masyarakat. Temuan lainnya dari hasil penelitian (Lopez, 2009), *Assessing rural community empowerment what it takes to think innovatively A doctoral research proposal*, mengungkapkan adanya hubungan antara pemberdayaan dengan tujuan inovasi dalam mencari peningkatan kondisi kehidupan berdasarkan perbedaan tingkat-tingkat modal sosial. Promosi Kesehatan dalam modal sosial dan pemberdayaan dapat menyumbangkan pengaruh pada pembangunan melalui aksi perorangan ataupun masyarakat yang didukung oleh kebijakan dan program.

Masalah-masalah yang menyebabkan program pemberantasan penyakit menular tidak berhasil di lingkungan masyarakat dan komunitas adalah kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya pemberantasan penyakit menular, sehingga tidak berperan aktif untuk terlibat berpartisipasi dalam program. Keterbatasan sumber daya, program

pemberantasan penyakit menular memerlukan sumber daya yang cukup, seperti dana, tenaga kerja dan peralatan. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan program tidak berhasil. Kurangnya koordinasi antara instansi, program pemberantasan penyakit menular memerlukan koordinasi yang baik antara instansi kesehatan, pemerintahan dan masyarakat. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan program tidak berhasil. (Suleaman, ES. 2012).

Kurangnya kemampuan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi penyakit menular dapat menyebabkan program tidak berhasil. Kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam program pemberantasan penyakit menular dapat menyebabkan program tidak berhasil. Kurangnya pemantauan dan evaluasi, program pemberantasan penyakit menular yang tidak memiliki pemantauan dan evaluasi yang baik dapat menyebabkan program tidak berhasil. Kurangnya dukungan politik, program pemberantasan penyakit menular yang tidak memiliki dukungan politik yang cukup dapat menyebabkan program tidak berhasil. Kurangnya sumber daya alam, program pemberantasan penyakit menular yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, seperti air bersih dan sanitasi, dapat menyebabkan program tidak berhasil. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit menular, masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakit menular dapat menyebabkan program tidak berhasil.

Diperlukan solusi mengatasi masalah program pemberantasan penyakit menular yang berbasis komunitas seperti: meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyakit menular.

B. Perawatan Kesehatan berbasis Komunitas

Keperawatan komunitas mengacu pada manusia yang merupakan titik sentral dari setiap upaya pembangunan kesehatan. Komunitas merupakan target pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai kesehatan komunitas, sebagai suatu upaya peningkatan kesehatan dan menggunakan kerjasama sebagai suatu mekanisme dalam mempermudah pencapaian tujuan yang berarti masyarakat/komunitas dilibatkan secara aktif untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta komunitas diartikan sebagai suatu proses dimana individu, keluarga dan komunitas bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri dengan berperan sebagai pelaku kegiatan upaya peningkatan kesehatannya berdasarkan asas kebersamaan dan kemandirian (Wahit Iqbal Mubarak & Nurul Chayatin, 2011).

Keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok resiko tinggi. Salah satu kelompok resiko tinggi perawatan komunitas adalah kelompok dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan serta asuhan keperawatan, adalah: penderita penyakit menular (Pradley (1985), Logan dan Dawkin (1987).

Ada beberapa prinsip keperawatan komunitas, antara lain sebagai berikut:

1. Kemanfaatan

Intervensi atau pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas yang dilakukan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas, artinya ada keseimbangan antara manfaat dan kerugian

2. Otonomi

Dalam keperawatan komunitas, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih alternatif terbaik yang disediakan

3. Keadilan

Hal ini menegaskan bahwa upaya atau Tindakan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan atau kapasitas komunitas

Tujuan keperawatan komunitas adalah untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pelayanan keperawatan secara langsung (*direct care*) terhadap individu, keluarga dan kelompok dalam konteks komunitas.
2. Perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat (*health general general community*) dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keluarga, individu dan kelompok.

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas berfokus pada kebutuhan dasar komunitas yang berkaitan dengan kebiasaan atau pola perilaku masyarakat yang tidak sehat serta ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal. Salah satu intervensi keperawatan komunitas adalah melakukan pendidikan kesehatan dan mendemostrasikan keterampilan dasar yang dapat dilakukan di komunitas. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut maka komunitas harus diberikan kemampuan untuk mandiri. Upaya pemberdayaan di komunitas harus diberikan.

Pemberdayaan dipandang sangat penting berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat
2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa
3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh
4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis dan mandiri.

Jika ditelaah dari pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan tujuan pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, diantaranya melalui pemberdayaan potensi lingkungan.

Hal ini sejalan dengan program kerja pemberdayaan keluarga mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: menumbuhkembangkan potensi keluarga, mengembangkan gotong-royong keluarga, mengali kontribusi keluarga, menjalin kemitraan dan desentralisasi serta mengembangkan sumber daya, meningkatkan pengetahuan keluarga. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya. Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.

Program memandirikan/pemberdayaan kepada komunitas diharapkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat mempunyai kemampuan untuk:

1. Berdaya dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami
2. Berdaya dalam menetapkan masalah kesehatan dan memprioritas masalah
3. Berdaya dalam merumuskan serta memecahkan masalah kesehatan
4. Berdaya dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi
5. Berdaya dalam mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi
6. Berdaya dalam memelihara Kesehatan secara mandiri (*self care*)

Upaya memberikan kemandirian/pemberdayaan kepada komunitas dalam program pemberantasan penyakit menular dengan menggunakan strategi intervensi keperawatan komunitas yaitu:

1. Proses Kelompok (*Group Process*)

Seseorang dapat mengenal dan mencegah penyakit, tentunya setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, selain dari faktor pendidikan/pengetahuan individu, media massa, televisi, penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan sebagainya. Begitu juga dengan masalah kesehatan di lingkungan sekitar masyarakat, tentunya gambaran penyakit yang paling sering mereka temukan sebelumnya sangat mempengaruhi upaya penanganan atau pencegahan penyakit yang mereka lakukan. Jika masyarakat sadar bahwa penanganan yang bersifat individual tidak akan mampu mencegah, apalagi memberantas penyakit tertentu, maka mereka telah melakukan pendekatan pemecahan masalah kesehatan menggunakan proses kelompok.

2. Pendidikan Kesehatan (*Health Promotion*)

Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tersebut bukan sekadar proses transfer materi/teori dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur. Akan tetapi, perubahan tersebut terjadi adanya kesadaran dari dalam diri individu, kelompok atau masyarakat sendiri. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar komunitas, mampu:

- a. Menetapkan masalah dan kebutuhan komunitas
- b. Memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya, dengan sumber daya yang ada pada komunitas dan ditambah dengan dukungan dari luar
- c. Memutuskan kegiatan yang paling tepat guna, untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan komunitas. (Wahit Iqbal Mubarak & Nurul Chayatin, 2011)

Menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 maupun WHO, Tujuan pendidikan kesehatan yaitu: meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental dan sosial. Sehingga produktif secara ekonomi maupun secara sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan terutama pada program pemberantasan penyakit menular. Jika dirinci tujuan pendidikan kesehatan adalah:

- a. Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat
- b. Mendorong individu agar mampu, baik secara mandiri atau kelompok, mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat

- c. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan Kesehatan yang ada.

3. Kerjasama (*Partnership*)

Berbagai persoalan kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi ancaman bagi lingkungan masyarakat luas. Oleh karena itu, kerja sama sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan komunitas, melalui upaya ini berbagai persoalan di dalam lingkungan masyarakat akan dapat diatasi dengan lebih cepat.

Secara umum sasaran keperawatan komunitas adalah seluruh masyarakat: termasuk individu, keluarga dan kelompok, baik yang sehat maupun yang sakit, khususnya mereka yang berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Individu

Individu adalah anggota keluarga sebagai kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Apabila individu tersebut mempunyai masalah Kesehatan karena ketidakmampuan merawat dirinya sendiri oleh karena sesuatu hal dan sebab, maka akan dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya dan keluarga yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal.

2. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi. Antara keluarga satu dan lainnya saling tergantung dan berinteraksi. Apabila salah satu atau beberapa anggota keluarga mempunyai masalah Kesehatan, maka akan berpengaruh terhadap anggota yang lainnya dan keluarga yang ada disekitarnya. Dari permasalahan tersebut diatas, maka keluarga merupakan focus pelayanan Kesehatan yang strategis, sebab:

- a. Keluarga sebagai Lembaga yang perlu diperhitungkan
- b. Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan Kesehatan seluruh anggota keluarga
- c. Masalah Kesehatan dalam keluarga saling berkaitan
- d. Keluarga sebagai tempat pengambilan keputusan (decision making) dalam perawatan Kesehatan.
- e. Keluarga merupakan perantara yang efektif dalam berbagai usaha-usaha Kesehatan masyarakat

3. Kelompok Khusus

Kelompok khusus adalah sekumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, usia, permasalahan (problem). Kegiatan yang terorganisasi sangat rawan terhadap masalah kesehatan. Kelompok khusus dapat di klasifikasikan:

- a. Kelompok dengan kebutuhan Kesehatan khusus sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan, seperti : ibu hamil dan ibu bersalin, ibu nifas, kelompok bayi, kelompok balita, kelompok anak usia sekolah dan kelompok usia lanjut.
- b. Kelompok dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan serta asuhan keperawatan, yaitu : Penderita penyakit menular, seperti: kelompok penderita penyakit kusta, kelompok penderita penyakit kelamin (gonorhea, sifilis), kelompok penderita HIV/AIDS, kelompok penyakit tidak menular, kelompok cacat yang memerlukan rehabilitasi, kelompok cacat mental dan kelompok cacat sosial

4. Kelompok yang mempunyai risiko tinggi terserang penyakit, yaitu:

- a. Kelompok penyalahgunaan obat dan narkotika
- b. Kelompok Wanita Tuna Susila (WTS) dan Pekerja seks Komersial (PSK)
- c. Kelompok pekerja tertentu. (Adi, 2001)

C. Program Pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang mencakup upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan maupun pemulihan secara tersendiri atau menyeluruh.

Cara-cara peran serta masyarakat ini dicerminkan dalam 3 bentuk yaitu:

1. Ikut dalam penelaahan situasi masalah
2. Ikut serta dalam Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemecahan masalah termasuk penentuan prioritas
3. Menjalankan kebiasaan hidup sehat dan berperan serta dalam upaya Kesehatan kuratif dan preventif.

Dalam rangka membangun kapasitas program pemberantasan penyakit menular dengan melibatkan masyarakat perlu diberikan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Ada 2 cara untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi dengan paksaan (*enforcement participation*), yaitu memaksa masyarakat untuk handil dalam suatu program baik melalui perundangan, peraturan, maupun perintah lisan. Hasilnya biasanya cepat terlihat, tetapi masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap program.

2. Partisipasi dengan persuasi dan edukasi yaitu : suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai, masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap program tersebut.

Elemen-elemen partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Motivasi. Motivasi harus dari masyarakat itu sendiri, untuk menumbuhkan motivasi masyarakat maka diberikan Pendidikan Kesehatan.
2. Komunikasi, suatu komunikasi yang baik adalah yang bisa menyampaikan ide, pesan dan informasi yang jelas kepada masyarakat.
3. Kooperasi, terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, bisa membantu untuk menumbuhkan partisipasi.
4. Mobilisasi, artinya partisipasi tidak sebatas tahap pelaksanaan program, tapi mulai dari mengidentifikasi adanya masalah, sampai monitoring pelaksanaan program.

Metode untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat adalah:

1. Pendekatan terhadap masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati. Pendekatan ditujukan kepada tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal.
2. Pengorganisasian masyarakat dan pembentukan Tim
3. Survei mawas diri, setiap tim kerja melakukan survey di masyarakat masing-masing dan mempresentasikan kepada warganya.
4. Perencanaan program. Perencanaan dibuat oleh masyarakat setelah dilakukan survey. Perlu juga dibentuk dana sehat dan kader Kesehatan sebagai bentuk partisipasi dalam hal dana, juga motor penggerak program, selanjutnya kader Kesehatan merupakan salah satu bentuk partisipasi tenaga dan juga sebagai dinamisor.
5. Pembelajaran dan pelatihan, f). Rencana evaluasi, perlu ditetapkan beberapa kriteria keberhasilan program secara sederhana yang mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. (Suleaman, ES. (2012).

Program pemberantasan penyakit menular disusun berdasarkan model PRECEDE-PROCEED menurut Green LW dan Kreuter MW (2005) merupakan model partisipatif untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan intervensi kesehatan masyarakat lainnya. Kerangka kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Tujuan program ini adalah menganalisis penilaian kualitas hidup, penyebaran masalah Kesehatan spesifik, perilaku dan lingkungan, Pendidikan dan pengorganisasian, administrasi dan kebijakan, implementasi,

evaluasi, proses, dampak dan hasil serta merumuskan perencanaan promosi Kesehatan dan pemberdayaan program pemberantasan penyakit menular.

Model PRECEDE-PROCEED menyediakan struktur yang komprehensif untuk menilai kesehatan dan kualitas hidup, serta untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Model PRECEDE-PROCEED terdiri dari sembilan fase/langkah yang dimulai dari konsekuensi akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Model ini memiliki dua bagian, yaitu:

1. PRECEDE, (*Predisposing Reinforcing and Enabling constructs in educational, Environmental diagnosis dan Evaluation*)
2. PROCEED (*Policy, Regulatory and Organisational Constructs in Educational and Development.*)

Model ini mencakup penambahan dimensi lingkungan yang telah diterapkan secara berhasil pada komunitas / masyarakat. Model *PRECEDE-PROCEED* terdiri dari 9 (Sembilan) fase/ Langkah yaitu :

Fase 1: Penilaian sosial (penilaian kualitas hidup) individu dan komunitas dalam populasi. Fokus dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah sosial yang berdampak pada kualitas hidup populasi. Hal ini memerlukan perencanaan program untuk memperoleh pemahaman tentang masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup menurut penilaian individu dan komunitas, selanjutnya menganalisis hubungan antara kualitas hidup dengan masalah Kesehatan spesifik yang menjadi fokus program pemberantasan penyakit menular. Menganalisis jalinan (link) bagaimana kualitas hidup mempengaruhi masalah sosial dengan metode penilaian sosial, seperti wawancara, forum komunitas, group nominal, focus group, survey masyarakat, dan pertemuan dengan organisasi setempat.

Fase 2: Penilaian epidemiologi (epidemiological diagnosis) untuk mengidentifikasi masalah Kesehatan spesifik yang memberikan kontribusi pada kualitas hidup. Fase ini bertujuan untuk menentukan masalah Kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidup, membantu mengidentifikasi factor-faktor perilaku dan lingkungan yang terkait dengan masalah kualitas hidup. Fokus dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi masalah Kesehatan dan factor di luar Kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidup buruk. Selanjutnya mengidentifikasi masalah Kesehatan spesifik yang memberikan kontribusi pada masalah sosial. Selanjutnya menetapkan prioritas masalah Kesehatan, identifikasi masalah sumber daya.

- Fase 3: Penilaian perilaku dan lingkungan yang berhubungan dengan masalah Kesehatan spesifik pada fase 2. Fase ini memfokuskan pada identifikasi sistematis praktik kesehatan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang ditetapkan pada fase 2, termasuk penyebab non-perilaku (factor personal dan lingkungan) yang dapat menyebabkan masalah Kesehatan tetapi tidak dikendalikan oleh perilaku, seperti factor genetic, usia, jenis kelamin, penyakit, iklim dan tempat kerja, kecukupafasilitas Kesehatan.
- Fase 4: Penilaian pendidikan dan pengorganisasian (*Education and organizational diagnosis*) : mengidentifikasi Pendidikan, keterampilan, pengorganisasian dan lingkungan kesehatan yang dibutuhkan serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku kesehatan ke dalam faktor kecenderungan (*predisposing factors*), faktor memungkinkan (*enabling faktors*) dan faktor memperkuat (*reinforcing factors*). Fase 4 dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih dan mengkategorikan pada tiga kelompok dari faktor-faktor yang berpotensi pada Kesehatan dan perubahan perilaku yaitu factor kecenderungan, memperkuat dan memungkinkan.
- Fase 5: Penilaian administrasi dan kebijakan (*administrasi and policy diagnosis*). Fokus pada kebijakan yang ditujukan sebelum implementasi program, termasuk penilaian sumber daya , pengembangan dan alokasi anggaran, penyusunan jadwal pelaksanaan, organisasi atau personil program serta koordinasi dan Kerjasama lintas program dengan semua unit pelaksana lain dan Kerjasama lintas sectoral dengan organisasi terkait dan masyarakat, serta menentukan komponen atau pelayanan program.
- Fase 6: Pelaksanaan (*Implementasi*) yaitu melaksanakan kebijakan, pengorganisasian dan perencanaan, metode dan strategi intervensi, mengembangkan dan mengimplementasikan program dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya, pembatasan waktu, kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.
- Fase 7: Evaluasi proses (*process evaluation*) diarahkan pada proses promosi kesehatan dan pemberdayaan pada program P2DBD dan P2TB. Evaluasi proses digunakan untuk mengevaluasi proses dimana proses promosi kesehatan dan pemberdayaan dilakukan.
- Fase 8: Evaluasi dampak (*impact evaluation*), mengukur efektivitas program promosi Kesehatan dan pemberdayaan dalam pencapaian tujuan dan perubahan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku Kesehatan meliputi factor

kecenderungan, memungkinkan dan memperkuat. Selanjutnya diharapkan dari hasil evaluasi masyarakat mampu :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan permasalahan
- b. Menentukan prioritas kebutuhan permasalahan
- c. Mengetahui sumber daya yang dimiliki
- d. Semakin banyak pemimpin dan kader local yang muncul
- e. Masyarakat makin mandiri
- f. Menyelesaikan permasalahan sendiri
- g. Swadaya masyarakat semakin kuat

Fase 9: Evaluasi hasil akhir (outcomes), mengukur berubah dalam hal tujuan keseluruhan dan perubahan dalam Kesehatan dan manfaat sosial atau kualitas hidup. Evaluasi hasil akhir Kesehatan (health outcome evaluation) adalah suatu evaluasi yang menilai perubahan atau perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas, status gizi atau indikator derajat Kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu. (Suleaman, 2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup individu dan masyarakat dinilai dari tingkat pendidikan, status ekonomi, pekerjaan, penghasilan dan ketaatan dalam beribadah. Program pemberantasan penyakit menular memprioritaskan penyakit DBD dan TB. Faktor kecenderungan meliputi tingkat Pendidikan, pengetahuan, keyakinan, serta kepercayaan kepada takhayul dan dukun. Faktor memungkinkan meliputi pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh petugas Kesehatan, ketersediaan sarana Kesehatan di desa seperti, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa, Forum Kesehatan, dukungan dana, sumberdaya lokal, kader kesehatan. Faktor penguat meliputi kepemimpinan desa, keteladanan, dukungan sosial, modal sosial akses informasi Kesehatan. Faktor penghambat yaitu kepercayaan pada tradisi.

Program pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas, untuk kasus Program P2DBD lebih diarahkan pada kegiatan pertolongan pertama dalam mengobati/merawat/merujuk penderita DBD ke rumah sakit, pemeriksaan jentik berkala, menyelenggarakan pelatihan petugas penyemprot, menyelenggarakan pertemuan/pelatihan/pembinaan kader dan juru pementau jentik, pelatihan penyuluhan intensif, melaksanakan system kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB. Selanjutnya untuk masalah penyakit TB lebih focus upaya penanggulangan TB diarahkan pada penapaian Visi program pemberantasan penyakit menular (TB) berbasis komunitas adalah menuju masyarakat bebas masalah penyakit TB, sehat, mandiri dan berkeadilan, serta pencapaian misi: meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian TB, menjamin ketersediaan pelayanan TB yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, menjamin ketersediaan

dan pemerataan sumberdaya pengendalian TB dan menciptakan tata Kelola program TB yang baik.

Implementasi program yang diperlukan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam: a) melakukan identifikasi masalah Kesehatan yang ada di masyarakat, khususnya masalah penyakit DBD dan TB, b) melakukan identifikasi potensi sumberdaya local, c) pembelajaran dan pelatihan kader DBD dan TB.

Evaluasi proses meliputi: jumlah penyuluhan, sosialisasi dan mobilisasi masyarakat untuk pemberantasan sarang nyamuk (PSN), P2DBD dan P2TB, frekuensi dan jenis pembelajaran dan pelatihan, jumlah tokoh masyarakat yang ikut serta, dan pertemuan masyarakat. Selanjutnya evaluasi proses pemberantasan DBD dan penanggulangan TB meliputi: Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengobatan dini, peningkatan upaya pemberantasan vector penularan penyakit DBD dan penemuan dini penderita tersangka TB.

D. Hambatan dalam Upaya Pemberantasan Penyakit Menular Berbasis Komunitas dengan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan mengidentifikasi dan pemecahan masalah kesehatan, hal ini terjadi karena tidak meratanya tingkat pendidikan, pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan kebiasaan dari masyarakat. Selanjutnya dari faktor penguat yang menjadi hambatan adalah akses informasi, peran petugas Kesehatan dan fasilitator, kepemimpinan, dan modal sosial yang masih minimal dalam menunjang keberhasilan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdaya untuk solid memberantaskan penyakit menular di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Hambatan terhadap kemampuan pemecahan masalah kesehatan dari komunitas dan peran pemerintah desa adalah disebabkan faktor-faktor dari tingkat Pendidikan, pengetahuan, kesadaran, status sosial, modal sosial, partisipasi masyarakat, sumber daya lokal, Musyawarah masyarakat desa (MMD), peran petugas kesehatan dan fasilitator, peran pemerintah desa, instansi pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten serta dukungan sumber daya dari pemerintah. (Suleaman et al., 2014)

E. Kesimpulan

Komunitas merupakan target pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai kesehatan komunitas, sebagai suatu upaya peningkatan kesehatan dan menggunakan kerjasama sebagai suatu mekanisme dalam mempermudah pencapaian tujuan yang berarti masyarakat /komunitas dilibatkan secara aktif untuk

mencapai tujuan tersebut. Peran serta komunitas diartikan sebagai suatu proses dimana individu, keluarga dan komunitas bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri dengan berperan sebagai pelaku kegiatan upaya peningkatan kesehatannya berdasarkan asas kebersamaan dan kemandirian (Wahit Iqbal Mubarak & Nurul Chayatin, 2011).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya suatu penyakit terutama penyakit menular maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dinilai dari tingkat pendidikan, status ekonomi, pekerjaan, dan penghasilan. Masalah kesehatan di masyarakat saat ini yang menjadi prioritas dan memberikan kontribusi pada kualitas hidup adalah penyakit DBD dan TB.

Program pemberantasan penyakit menular di lingkungan masyarakat akan mencapai tujuan bila melibatkan peran aktif masyarakat/komunitas di lingkungannya. Maka perlu disusun program pemberantasan penyakit menular berbasis komunitas sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia dimasyarakat Masyarakat sangat perlu diberdayakan dalam program pemberantasan penyakit menular meliputi upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit. Pemberdayaan masyarakat diperlukan pelatihan kepada masyarakat secara kontinue dan berkala selanjutnya dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh pihak terkait sehingga memastikan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

F. Referensi

- Achmadi,UF. (2010). Seri Desentralisasi Kesehatan Masyarakat, Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah, Universitas Indonesia (UI-Press), 2010
- Adi. 2001. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Jakarta. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- American Nurses Association, Council of Community Health Nurses, 1986. Standar of Community Health Nursing Practice. Kansas City: ANA.
- Aziz. 2005. Pendekatan Sosio-kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam model-model Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan I. Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Buditama dan Rudito. 2008. Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development. Cetakan Kedua ICSD (Indonesian Center for sustainable Development). Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2007. Paket Informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas. Jakarta.

- Dewi. 2003. Menuju Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan Melalui Komite Kesehatan Dusun, Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Ke-3, Yogyakarta, 1-3 September 2003.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2011. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat, Bandung.
- Effendy Nasrul.1998. Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan masyarakat. Jakarta: EGC.
- FEUI. 2000. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Penerbit FE UI
- Lonnroth K et al. (2009). Drivers of Tuberculosis epidemics: the role of risk factors and social determinants. *Social Science & Medicine*
- Lopez. (2009), *Assessing rural community empowerment what it takes to think innovatively A doctoral research proposal*,
- Maldonado RW and Merril SB. 2002. Building Partnertship with the community: Lessons from the Camden Health Improvement Learning Collaborative. *Journal of Health Care Management* Pemerintah RI dan UNICEF (2002). Panduan Umum Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Jakarta.
- Notoadmojo, Soekidjo, 1997. Bina Diknakes. Edisi No.23 Pengembangan Sumber Daya Manusia dikaitkan dengan Pelayanan Kesehatan.
- Notoadmojo, Soekidjo,2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Shrestha. (2013). *A conseptual model for empowerment of the famele community health volunteers in Nepal*,
- Spradley, B.W dan Allender, J.A.2001. Community Health Nursing: Concepts and Practice. 5th ed. Philadelphia: lipincott.
- Stanhope & Lancaster, 1989. Community Health Nursing, Process and Practise for Promoting Health, St.Louis:CV. Mosby Company.
- Suleaman ES (2015). Manajemen Masalah Kesehatan dan Manajemen Strategis Organisasi Layanan Kesehatan. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Suleaman, ES. (2012). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi. Gadjah Mada University Press,2012.
- Suleman ES. (2017). Model Perencanaan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan (Studi Kasus Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue dan Tuberkulosis), UNS PRESS, 2017.
- Varkey,Kureshi, Lesnick.(2010). *Empowerment of women and its association with the health of the community*
- Wahit Iqbal Mubarak & Nurul Chayatin. (2011). Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan teori, Penerbit Salemba Medika, 2009

CHAPTER 7

EVALUASI EFEKTIVITAS KAMPANYE KESEHATAN

Fitriah, S.K.M., M.K.M.

A. Pendahuluan

Kampanye kesehatan berbasis komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong perubahan perilaku terkait isu-isu kesehatan. Kampanye ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai sarana advokasi yang dapat memengaruhi kebijakan kesehatan publik. Evaluasi terhadap kampanye kesehatan berbasis komunitas menjadi aspek fundamental untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam inisiatif kesehatan di masa depan (Sundstrom et al., 2018).

Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam perancangan dan implementasi strategi komunikasi kesehatan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pendekatan *top-down* yang hanya berfokus pada penyampaian informasi tanpa interaksi yang cukup dengan masyarakat (Sundstrom et al., 2018). Kampanye yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat cenderung menghasilkan dampak jangka panjang, baik dalam perubahan perilaku individu maupun dalam peningkatan literasi kesehatan secara kolektif. Sebagai contoh, pendekatan ini telah digunakan dalam program-program promosi kesehatan yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi mengenai pola hidup sehat.

Namun, evaluasi efektivitas kampanye kesehatan tidak selalu mudah dilakukan. Salah satu tantangan utama adalah pengukuran dampak kampanye terhadap perubahan perilaku masyarakat. Hofer et al. (2021) menyoroti bahwa evaluasi yang efektif harus memperhitungkan berbagai metrik perilaku serta tantangan seperti konsistensi pengukuran dan bias laporan diri, yang sering muncul dalam penelitian komunikasi kesehatan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi penerimaan pesan kampanye oleh masyarakat.

Beberapa kampanye kesehatan yang telah berhasil menunjukkan pentingnya pendekatan multifaset dalam penyampaian pesan kesehatan. Studi Nirmal et al. (2024) mengungkapkan bahwa kampanye kesehatan yang mengintegrasikan elemen interaktif lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat serta mempercepat perubahan perilaku. Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan

Sood et al. (2014), yang menyatakan bahwa kampanye media massa akan lebih efektif jika menjadi bagian dari strategi sosio-ekologis yang mencakup inisiatif komunitas dan kebijakan pendukung. Dengan demikian, kampanye kesehatan yang sukses tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain aspek komunikasi, keberhasilan kampanye kesehatan juga dipengaruhi oleh dukungan tenaga kesehatan, motivasi individu, serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Studi oleh Nina & Supriyatna (2021) menunjukkan bahwa promosi kesehatan, keterlibatan tenaga kesehatan, serta dukungan dari guru memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program kader kesehatan remaja. Penelitian lain oleh Manggala et al. (2021) menegaskan bahwa program berbasis komunitas yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye tidak hanya ditentukan oleh strategi komunikasi yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana kampanye tersebut diintegrasikan dalam struktur sosial komunitas yang bersangkutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital semakin berperan dalam kampanye kesehatan. Isyofi et al. (2024) menyoroti bahwa penggunaan platform digital dapat meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan dan memperbaiki kualitas kampanye kesehatan. Hal ini terbukti terutama selama pandemi COVID-19, dimana WHO & UNICEF (2022) menekankan pentingnya komunikasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan serta mengatasi tantangan infodemik yang sering kali menghambat efektivitas kampanye kesehatan. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam kampanye kesehatan dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan jangkauan dan efektivitas kampanye di masa depan.

Salah satu contoh kampanye kesehatan yang telah berhasil dalam meningkatkan perubahan perilaku adalah kampanye *Tips From Former Smokers* yang diselenggarakan oleh CDC. Kampanye ini menggunakan pendekatan berbasis kisah nyata untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, dengan menampilkan testimoni dari mantan perokok yang mengalami berbagai dampak kesehatan akibat kebiasaan tersebut. Kampanye ini terbukti berhasil mendorong jutaan perokok untuk berhenti, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman nyata dapat meningkatkan efektivitas kampanye kesehatan (CDC, 2024).

Evaluasi kampanye kesehatan juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan. Kampanye yang memiliki dampak positif terhadap perilaku

kesehatan masyarakat dapat berkontribusi pada pengurangan beban biaya pelayanan kesehatan dalam jangka panjang. Evaluasi berbasis biaya-manfaat dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas kampanye dan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih efisien. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam evaluasi, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan umpan balik, dapat meningkatkan relevansi dan penerimaan hasil evaluasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kampanye kesehatan, evaluasi menjadi langkah penting dalam mengukur dampaknya terhadap perubahan perilaku dan kesehatan masyarakat. Evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam implementasi kampanye. Selain itu, evaluasi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Kampanye kesehatan yang terencana dengan baik dan didukung oleh evaluasi yang sistematis akan memiliki potensi lebih besar dalam menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

B. Prinsip Kampanye Kesehatan yang Efektif

Kampanye kesehatan yang efektif harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi strategis dan berbasis bukti. Beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam penyusunan kampanye kesehatan agar mencapai hasil yang optimal meliputi:

1. Menentukan Tujuan Kampanye yang Jelas

Tujuan yang jelas dan terukur merupakan fondasi utama dalam kampanye kesehatan yang sukses. Pendekatan SOCO (*Single Overarching Communication Outcome*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan spesifik yang diharapkan dari kampanye. Dengan metode ini, setiap kampanye memiliki target yang dapat diukur dan ditindaklanjuti, sehingga efektivitasnya dapat dievaluasi secara sistematis (WHO, 2022).

2. Menentukan Audiens Target

Identifikasi audiens target sangat penting agar pesan kampanye tepat sasaran. WHO (2022) mengklasifikasikan audiens kampanye menjadi beberapa kategori:

- a. *Champions* (Pendukung Utama) merupakan individu atau kelompok yang secara aktif menyebarkan pesan kampanye dan memiliki pengaruh besar dalam komunitas.
- b. *Silent Boosters* (Pendukung Pasif) yakni mereka yang mendukung kampanye tetapi tidak secara aktif terlibat dalam promosi.

- c. *Blockers* (Penghalang) adalah kelompok yang menentang kampanye karena alasan tertentu.
- d. *Avoiders* (Penghindar) yakni individu yang kurang peduli atau tidak menunjukkan minat terhadap isu yang disampaikan.

3. Pengembangan Pesan Kunci

Agar kampanye kesehatan efektif, pesan yang disampaikan harus berbasis data ilmiah, tetapi tetap mampu membangkitkan emosi dan mudah dipahami oleh audiens. Model yang digunakan mengadaptasi model komunikasi SUCCESS (Heath & Heath, 2007) yang mencakup:

- a. *Simple* (Sederhana): Pesan yang jelas dan tidak rumit agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
- b. *Unexpected* (Tak Terduga): Elemen kejutan dalam pesan yang dapat menarik perhatian audiens.
- c. *Concrete* (Konkret): Menyediakan informasi yang nyata dan dapat diingat dengan mudah.
- d. *Credible* (Kredibel): Didukung oleh sumber terpercaya dan bukti ilmiah.
- e. *Emotional* (Emosional): Menggunakan pendekatan yang menyentuh emosi untuk meningkatkan keterlibatan audiens.
- f. *Stories* (Cerita): Menggunakan narasi atau kisah nyata untuk memperkuat pesan kampanye.

4. Menggunakan Media dan Taktik yang Tepat

Pemilihan media dan strategi komunikasi harus disesuaikan dengan audiens yang ditargetkan. Berbagai saluran komunikasi dapat digunakan, antara lain:

- a. Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) – Menjangkau audiens lebih luas secara interaktif.
- b. Televisi dan radio – Mengakses masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap internet.
- c. Selebaran dan poster – Media cetak untuk menyebarluaskan informasi di tempat umum.
- d. Pertemuan komunitas – Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung.
- e. Advokasi kebijakan – Menggunakan pendekatan legislatif untuk mendorong perubahan kebijakan kesehatan masyarakat.

5. Mendorong Perubahan Kebijakan Kesehatan

Kampanye kesehatan yang sukses tidak hanya bertujuan mengubah perilaku individu tetapi juga harus mampu mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas. Beberapa contoh kampanye berbasis kebijakan yang telah sukses meliputi:

- a. Pembatasan iklan rokok untuk mengurangi tingkat merokok di kalangan remaja.
- b. Regulasi pajak minuman berpemanis untuk menekan angka obesitas.
- c. Peningkatan infrastruktur jalur sepeda dan pejalan kaki guna meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

C. Indikator Evaluasi Kampanye Kesehatan

Evaluasi kampanye kesehatan memerlukan kerangka kerja dan indikator yang jelas untuk memastikan efektivitasnya. Berdasarkan sistem pengukuran *Primary Health Care* (PHC) WHO & UNICEF (2022) indikator evaluasi kampanye kesehatan dapat dikelompokkan menjadi enam aspek utama:

1. Akses dan Adopsi Teknologi

Teknologi memainkan peran penting dalam efektivitas kampanye kesehatan, terutama di era digital. Indikator yang dapat digunakan meliputi:

- a. Jumlah individu yang mendapatkan akses ke platform digital atau materi kampanye.
- b. Frekuensi penggunaan platform atau materi kesehatan berbasis digital.
- c. Tingkat literasi digital peserta sebelum dan sesudah kampanye.

2. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran

Menurut *Diffusion of Innovations Theory* (Rogers, 1983) peningkatan pengetahuan merupakan langkah awal dalam perubahan perilaku. Indikatornya meliputi:

- a. Perubahan tingkat pengetahuan peserta mengenai isu kesehatan yang disosialisasikan.
- b. Persentase peserta yang dapat mengidentifikasi gejala atau masalah kesehatan yang dibahas dalam kampanye.
- c. Jumlah pertanyaan atau diskusi yang muncul dari peserta selama dan setelah kampanye berlangsung.

3. Perubahan Sikap dan Persepsi

Berdasarkan *Social Cognitive Theory* oleh Bandura (1986), perubahan sikap mempengaruhi adopsi perilaku sehat. Indikatornya meliputi:

- a. Perubahan persepsi terhadap topik kesehatan yang menjadi fokus kampanye (misalnya, penurunan stigma terhadap kesehatan mental).
- b. Tingkat kepercayaan diri peserta dalam mengakses layanan kesehatan.
- c. Sikap peserta terhadap teknologi sebagai alat bantu informasi kesehatan.

4. Perubahan Perilaku Kesehatan

Evaluasi dampak kampanye juga harus mencakup perubahan perilaku, sebagaimana dijelaskan dalam *Community-Based Participatory Research* (CBPR) Model (Ginossar & Nelson, 2010). Indikatornya meliputi:

- a. Peningkatan jumlah individu yang mencari atau mengakses layanan kesehatan setelah kampanye.
- b. Persentase individu yang menerapkan perubahan perilaku kesehatan setelah mengikuti kampanye.
- c. Jumlah individu yang merekomendasikan kampanye atau layanan kesehatan kepada orang lain.

5. Keterlibatan dan Partisipasi Komunitas

Berdasarkan studi *promotoras de salud* dalam kampanye kesehatan, keterlibatan komunitas sangat mempengaruhi efektivitas kampanye (Ginossar & Nelson, 2010). Indikatornya meliputi:

- a. Jumlah peserta yang berpartisipasi aktif dalam diskusi, pelatihan, atau kegiatan kampanye lainnya.
- b. Jumlah kontribusi dari komunitas dalam menciptakan atau menyebarkan konten kesehatan.
- c. Keberlanjutan partisipasi setelah kampanye selesai (misalnya, penggunaan platform atau partisipasi dalam program lanjutan).

6. Evaluasi Dampak Jangka Panjang

Untuk menilai keberlanjutan dampak kampanye, indikator yang dapat digunakan meliputi:

- a. Perubahan dalam pola layanan kesehatan komunitas dalam jangka waktu tertentu.
- b. Tingkat kepuasan peserta terhadap kampanye dan informasi yang diberikan.
- c. Implementasi model yang dikembangkan dalam kampanye ke wilayah lain atau komunitas berbeda.

D. Metode Evaluasi Kampanye Kesehatan

Untuk memastikan keberhasilan kampanye kesehatan berbasis komunitas, diperlukan metode evaluasi yang sistematis dan berbasis bukti. WHO & UNICEF, (2022) merekomendasikan beberapa pendekatan evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kampanye kesehatan:

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi ini dilakukan sebelum kampanye dimulai untuk memahami karakteristik audiens target dan menyusun strategi komunikasi yang sesuai.

Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi, hambatan dalam komunikasi, serta preferensi audiens dalam menerima pesan kesehatan.

Metode yang digunakan: Survei awal, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD).

2. Evaluasi Proses

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kampanye guna memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan: Jumlah materi kampanye yang didistribusikan, jumlah peserta yang terlibat, efektivitas saluran komunikasi yang digunakan. Metode evaluasi: Analisis data partisipasi, wawancara dengan penyelenggara, observasi langsung terhadap pelaksanaan kampanye.

3. Evaluasi Hasil (*Outcome Evaluation*)

Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak jangka pendek kampanye terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku audiens target setelah kampanye berlangsung.

Metode yang digunakan:

- a. Survei pasca-kampanye untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat.
- b. Analisis media sosial untuk melihat tingkat keterlibatan dan respons audiens.
- c. Wawancara lanjutan untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terkait isu kesehatan yang dikampanyekan.

4. Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*)

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efek jangka panjang kampanye terhadap pola kesehatan masyarakat. Evaluasi ini membutuhkan data longitudinal yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu untuk melihat perubahan yang lebih berkelanjutan.

Metode yang digunakan:

- a. Studi kohort untuk mengamati perubahan perilaku kesehatan dari waktu ke waktu.
- b. Analisis data epidemiologi untuk menilai perubahan prevalensi penyakit atau kondisi kesehatan tertentu.
- c. Wawancara dengan pemangku kepentingan untuk memahami dampak kebijakan yang dihasilkan dari kampanye kesehatan.

Metode Tambahan dalam Evaluasi Kampanye Kesehatan

Selain pendekatan evaluasi di atas, beberapa metode tambahan dapat digunakan untuk memperkaya hasil evaluasi kampanye kesehatan:

- a. Survei dan Kuesioner: Mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah kampanye.
- b. Studi Wawancara dan Fokus Grup Diskusi (FGD): Menggali pengalaman peserta kampanye serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung keberhasilan kampanye.
- c. Analisis Data Sekunder: Menggunakan data rekam medis, laporan kesehatan masyarakat, dan statistik resmi untuk menilai dampak kampanye.
- d. Observasi Langsung: Mengamati perilaku masyarakat dalam menerapkan pesan kampanye di kehidupan sehari-hari.
- e. Umpan Balik dari Stakeholder: Melibatkan pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kampanye.

E. Implementasi Evaluasi Kampanye Kesehatan

Implementasi evaluasi kampanye kesehatan harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program di masa depan. Evaluasi yang baik tidak hanya mengukur keberhasilan jangka pendek tetapi juga memastikan keberlanjutan dampak kampanye dalam jangka panjang (WHO, 2020).

1. Perencanaan Evaluasi

Tahap ini melibatkan identifikasi tujuan evaluasi, pemilihan metode yang sesuai, serta pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan. Tim evaluasi harus memastikan bahwa metode yang digunakan relevan dengan tujuan kampanye serta mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kampanye.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik, termasuk survei, wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), serta analisis data sekunder dari laporan kesehatan masyarakat atau rekam medis. Data yang dikumpulkan harus valid dan dapat diandalkan untuk memberikan gambaran akurat tentang dampak kampanye.

3. Analisis Data dan Interpretasi

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas kampanye dalam mencapai perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, serta dampak jangka panjang terhadap kebijakan kesehatan. Interpretasi hasil harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi hasil evaluasi.

4. Pelaporan dan Diseminasi Hasil

Hasil evaluasi harus disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, akademisi, serta komunitas yang terlibat dalam kampanye. Laporan evaluasi harus mencakup ringkasan temuan utama, rekomendasi perbaikan, serta strategi untuk meningkatkan efektivitas kampanye di masa depan.

5. Pemanfaatan Hasil Evaluasi untuk Perbaikan Program

Evaluasi kampanye tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kampanye selanjutnya. Temuan evaluasi dapat digunakan untuk:

- a. Menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
- b. Mengoptimalkan alokasi sumber daya agar kampanye lebih efisien.
- c. Mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang mendukung keberlanjutan program kesehatan masyarakat.

F. Tantangan Evaluasi Kampanye Kesehatan

Evaluasi kampanye kesehatan sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasilnya. Tantangan utama meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Evaluasi yang menyeluruh memerlukan pendanaan, tenaga ahli, serta waktu yang cukup. Namun, banyak kampanye memiliki keterbatasan anggaran, yang menyebabkan kurangnya alokasi dana untuk penelitian dan evaluasi yang mendalam.

2. Kesulitan dalam Mengukur Perubahan Perilaku

Mengukur dampak kampanye terhadap perubahan perilaku sering kali kompleks karena banyak faktor eksternal yang turut mempengaruhi. Selain itu, efek kampanye mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, sehingga memerlukan studi longitudinal yang lebih mendalam.

3. Variabilitas Konteks Sosial dan Budaya

Efektivitas kampanye dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ditargetkan. Pendekatan yang berhasil di satu komunitas mungkin tidak memberikan hasil yang sama di komunitas lain.

4. Bias dalam Pengumpulan Data

Responden sering kali memberikan jawaban yang dianggap 'benar secara sosial' dalam survei atau wawancara, yang dapat menyebabkan bias dalam hasil evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih objektif dan triangulasi data dari berbagai sumber.

5. Kurangnya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan komunitas dalam proses evaluasi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Namun, banyak kampanye mengalami kesulitan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengumpulan data dan umpan balik.

6. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, keterbatasan akses terhadap teknologi digital dan sistem informasi kesehatan dapat menghambat pengumpulan serta analisis data evaluasi secara efisien.

G. Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital: Menggunakan platform online untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih efisien.
2. Peningkatan Kapasitas Evaluator: Melatih tenaga kesehatan dan peneliti dalam metode evaluasi berbasis bukti.
3. Kolaborasi Multisektoral: Melibatkan akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam proses evaluasi untuk memperkuat validitas hasil.
4. Pendekatan Partisipatif: Menggunakan metode evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti *citizen science* dan *participatory action research*.

H. Kesimpulan

Evaluasi kampanye kesehatan berbasis komunitas merupakan aspek esensial dalam memastikan keberhasilan kampanye dan memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Kampanye yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip komunikasi yang jelas, target audiens yang spesifik, serta pesan yang berbasis bukti dan menarik bagi masyarakat.

Indikator evaluasi harus mencakup berbagai aspek seperti akses informasi, peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Dengan menerapkan metode evaluasi yang sistematis, mulai dari evaluasi formatif hingga dampak jangka panjang, efektivitas kampanye dapat diukur secara lebih akurat.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam evaluasi kampanye, strategi seperti pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas evaluator, dan pendekatan partisipatif dapat membantu mengatasi hambatan yang ada. Dengan evaluasi yang berbasis bukti, kampanye kesehatan dapat terus berkembang dan

beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, memastikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan komunitas.

I. Referensi

- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. In *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall, Inc.
- CDC. (2024). Tips From Former Smokers: Evaluating the Impact of Real-Life Testimonials on Smoking Cessation. *The Campaign*, 1–5.
- Ginossar, T., & Nelson, S. (2010). Reducing the health and digital divides: A model for using community-based participatory research approach to e-health interventions in low-income hispanic communities. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 15(4), 530–551. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2009.01513.x>
- Heath, C., & Heath, D. (2007). Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Hofer, R., Wilkin, M., Mayers, E., Wolford, B., Butler, B. S., Beavers, B., & Zubieta, A. C. (2021). Development and Evaluation of a Research-Driven Health Communication Campaign to Increase Fruit and Vegetable Consumption Among SNAP-Eligible Ohio Adults. *Social Marketing Quarterly*, 27(4), 267–283. <https://doi.org/10.1177/15245004211042413>
- Isyrofi, A. Q. A. Al, Handayani, D., Ibad, M., Lestari, M. W., & Jauharoh, I. A. (2024). Kaderisasi Promotor Kesehatan Berbasis Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Promosi Kesehatan Di Era Digital. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 8(2), 170–179. <https://doi.org/10.52643/pamas.v8i2.2604>
- Manggala, T., Suminar, J. R., & Hafiar, H. (2021). Faktor-Faktor Keberhasilan Program Promosi Kesehatan “Gempur Stunting” Dalam Penanganan Stunting Di Puskesmas Rancakalong Sumedang. *Coverage Journal of Strategic Communication*, 11(2), 91–102. <https://doi.org/10.35814/coverage.v11i2.2016>
- Nina, N., & Supriyatna, R. (2021). Determinan Efektivitas Program Kader Kesehatan Remaja Di SMAN 01 Dramaga Bogor. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(02), 123–132. <https://doi.org/10.33221/jikm.v10i02.948>
- Nirmal, H., Ibrahim, K., & Khan, R. (2024). Hooked on Shisha: A 5-Year Study on Oral Health Risks and Awareness Campaigns in Leicester. *Journal of Medicine, Nursing & Public Health*, 7(3), 12–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.53819/81018102t2451>
- Rogers, E. M. (1983). Diffusion Of Innovations. In *The Free Press* (3rd ed.). <https://doi.org/10.4324/9781315263434-16>

- Sood, S., Shefner-Rogers, C., & Skinner, J. (2014). Health Communication Campaigns in Developing Countries. *Journal of Creative Communications*, 9(1), 67–84. <https://doi.org/10.1177/0973258613517440>
- Sundstrom, B., Brandt, H. M., Gray, L., & Pierce, J. Y. (2018). Student-Led Health Communication Strategies and Their Impact on Community Relationships and Health Literacy. *Journal of Communication Management*, 21(4), 342–354.
- WHO. (2020). *Community-based health care, including outreach and campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic*. May.
- WHO. (2022). Module 13-Effective Public Health Campaigns. *WHO*, 1–15. <https://doi.org/10.4135/9781452233451>
- WHO, & UNICEF. (2022). Primary health care measurement framework and indicators: monitoring health systems through a primary health care lens. In *World Health Organization*.

PROFIL PENULIS



Dr. Fenita Purnama Sari Indah, SKM., M.Kes., Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Widya Dharma Husada Tangerang. Penulis lahir di Bandar Lampung, 12 Juni 1991. Pada tahun 2009-2013 menempuh S1 Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Biostatistika di Universitas Diponegoro, Semarang. Melanjutkan studi S2 Kesehatan Masyarakat pada 2013 hingga 2015 di perguruan tinggi yang sama. Sejak September 2020-Januari 2024 penulis menempuh Pendidikan doktoral di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah nasional, internasional, maupun buku. Saat ini tercatat sudah pernah mendapatkan beberapa hibah penelitian berupa Penelitian Fundamental, Penelitian Dasar Kompetitif Nasional, Penelitian Dosen Pemula dan Hibah BKKBN. Penulis juga merupakan awardee Beasiswa LPDP. Kepakaran Penulis adalah Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, HIV/AIDS dan Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.". Penulis dapat dihubungi pada alamat email: fenita.purnama@masda.ac.id

Moto Penulis yaitu "*Work hard, Pray Hard and Thankful*"



Katarina Iit, SST., M.Kes., Lahir di Sei.Dangin, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Pada 27 Febuarri 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada Program Studi Bidan Pendidik, di Universitas Respati Indonesia tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak sebagai dosen Diploma III Kebidanan dan mengampu mata kuliah: Pengantar Asuhan Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Kespro & KB, Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui, Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: katarinaiit17@gmail.com

Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom., Lahir di Garut, 15 Juli 1964. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di PSIK FK Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di FIK Universitas Indonesia Jakarta, dan Pendidikan Doktoral Bidang Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pengalaman mengajar dimulai sejak tahun 1988 dalam Bidang Keperawatan, meliputi Keperawatan Dasar (Falsafah & Teori Keperawatan, Kebijakan Kesehatan) serta Keperawatan

Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik (KKG). Penulis juga aktif sebagai peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, penulis buku serta nara sumber terkait pengembangan keperawatan kesehatan masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui email: supriadifalah@gmail.com

Pesan untuk pembaca: Jadilah insan yang penuh manfaat untuk orang banyak, tidak ada kata malas membaca untuk hidup penuh arti dan bermanfaat.



Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M., Lahir di Kuningan, 15 September 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis D3 Kebidanan kemudian melanjutkan D4 Kebidanan, kemudian melanjutkan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat konsentrasi Promosi Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka Jakarta kemudian melanjutkan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi

Kesehatan Masyarakat, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan dan Teknologi Pengembangan Media. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, seminar, melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: risnanurlia@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Sukmah Fitriani, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom., menyelesaikan Program studi Magister Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pengalaman kerja Penulis pernah bekerja sebagai staff bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Saat ini sebagai Dosen di Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sukmafitriani@fk.unsri.ac.id.



Wittin Khairani, S.Pd., MPH., Lahir di Jambi, 21-November- 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Pendidikan Negeri Padang tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2009 Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Promosi Dan Perilaku Kesehatan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996, Guru Tetap di SPK Kesdam Palembang/Jambi, Pernah menjadi Dosen Tetap Akper Depkes Negeri Bandar Lampung (Poltekkes Kemenkes Bandar Lampung), Pernah menjadi Dosen Tetap Di Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi, Home care, dan perawatan jiwa (Perilaku Manusia). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku tentang promosi Kesehatan dan Perilaku sehat, publikasi di jurnal Nasional maupun Internasional, dan berperan aktif dalam seminar regional maupun Nasional, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: khairaniwittin@gmail.com
Motto: "Living your life well" (**opsional jika ingin ditambahkan**)



Fitriah, S.K.M., M.K.M., lahir di Sungai Pandan, 22 Desember 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Surya Global Yogyakarta. Kemudian, melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret dan lulus pada tahun 2022. Saat ini, penulis bekerja sebagai akademisi yang fokus pada bidang kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam penelitian, pengabdian masyarakat, maupun publikasi ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fitriahbaharuddin@gmail.com

Buku *"Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas"* merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai strategi dan pendekatan dalam mengembangkan promosi kesehatan yang efektif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat modern, keberhasilan program kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami karakteristik komunitas, memanfaatkan teknologi, serta membangun kolaborasi lintas sektor.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas peran teknologi dalam edukasi kesehatan masyarakat, termasuk pemanfaatan aplikasi digital dan platform daring. Bab kedua mengeksplorasi kekuatan media sosial dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pesan-pesan kesehatan yang menarik dan mudah dipahami.

Selanjutnya, buku ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan masyarakat—untuk memperluas cakupan promosi kesehatan. Pendekatan budaya yang peka terhadap nilai dan kebiasaan lokal juga diulas sebagai strategi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan kesehatan.

Tidak kalah penting, buku ini mengulas strategi pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri. Di samping itu, dibahas pula praktik-praktik dalam program pemberantasan penyakit menular yang berbasis komunitas, serta bagaimana melakukan evaluasi kampanye kesehatan secara sistematis untuk memastikan efektivitasnya.

Buku "Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas" merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai strategi dan pendekatan dalam mengembangkan promosi kesehatan yang efektif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat modern, keberhasilan program kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami karakteristik komunitas, memanfaatkan teknologi, serta membangun kolaborasi lintas sektor.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas peran teknologi dalam edukasi kesehatan masyarakat, termasuk pemanfaatan aplikasi digital dan platform daring. Bab kedua mengeksplorasi kekuatan media sosial dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pesan-pesan kesehatan yang menarik dan mudah dipahami.

Selanjutnya, buku ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperluas cakupan promosi kesehatan.

Pendekatan budaya yang peka terhadap nilai dan kebiasaan lokal juga diulas sebagai strategi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan kesehatan.

Tidak kalah penting, buku ini mengulas strategi pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri. Di samping itu, dibahas pula praktik-praktik dalam program pemberantasan penyakit menular yang berbasis komunitas, serta bagaimana melakukan evaluasi kampanye kesehatan secara sistematis untuk memastikan efektivitasnya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-52-7



9

786347

219527